studeersnel

Bệnh chó mèo - Hgcfg

Chuyên ngành Thú Y (Trường Đại học Cần Thơ)

Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

TS. VŨ NHƯ QUÁN

BỆNH CỦA CHÓ, MÈO

TÀI LIỆU HỌC TẬP DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH THÚ Y

(Lưu hành nội bộ)

Hà Nội 12 - 2008

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

ĐẶC TÍNH SINH HỌC CHỦ YẾU CỦA CHÓ

HỆ THỐNG XƯƠNG

Bộ xương là đòn bẩy của chuyển động, là chỗ tựa của những phần mềm trong cơ thể, là cơ quan bảo vệ, là chỗ để phát triển những cơ quan tạo máu (tủy xương đỏ), tham gia vào những quá trình trao đổi chất và sinh học trong cơ thể, là kho dự trữ của những chất vô cơ cũng như hữu cơ.

Bộ xương chó cấu trúc từ 247 xương và 262 khớp. Cột sống bao gồm 7 đs cổ, 13 đs ngực, 7 đốt sống thắt lưng, 3 đốt sống khum, 20 – 23 đs đuôi (một vài loài chỉ có 5 – 6 đốt sống đuôi. Chó có 13 đôi xương sườn.

Chân trước bắt đầu từ xương bả vai, x. cánh tay, x. cẳng tay (x. trụ và x. quay), x. cổ tay (có 7 x. nhỏ), x. bàn tay (có 5 xương), x. ngón tay (có 4 ngón 3 đốt, 1 ngón 2 đốt). Xương chân trước liên kết với các đốt sống không phải là khớp mà bằng những cơ chắc chắn. Phía trên x. bả vai là vây. Chiều cao vây là chiều cao của chó và là một chỉ tiêu xác định giá trị giống của nó. Độ lệch với tiêu chuẩn cao hơn giới hạn trên và thấp hơn giới hạn dưới được coi là khuyết tật.

Xương chân sau bắt đầu từ xương chậu, x. đùi, x. cẳng chân, x. cổ chân (có 7 xương nhỏ), x. bàn chân có 4 hoặc 5 xương, x. ngón chân có 4, đôi khi mặt trong từ nửa trên x. bàn có 1 ngón bất toàn (huyền đề) - không phải ở cá thể nào cũng liên kết với khối xương bàn chân. Ở nước ngoài, người ta coi nó như một hiện tượng không mong muốn, có thể cắt bỏ nó khi chó còn non; ở Việt Nam, người ta quan niệm như một cơ hội may mắn: “Dù ai buôn bán trăm nghề, không bằng nuôi chó huyền đề 4 chân”. Xương chân sau có một khớp nối với xương chậu (ổ cối), được cố định bằng các cơ của nhóm cơ chậu đùi.

HỆ THỐNG CƠ

Hệ thống cơ đóng vai trò quan trọng trong ngoại hình và mô hình hóa một cách nổi bật cơ thể chó. Trong các tiêu chuẩn đánh giá vẻ đẹp của chó, hệ cơ đóng vai trò quan trọng. Để chó có thân hình cân đối, hệ cơ cần được phát triển tốt, không có những dấu hiệu của sự quá béo hay quá gầy. Sự linh động và những khúc cong

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

của cơ thể là những nét đặc biệt phân biệt của động vật. Với mục đích bảo vệ năng lượng của cơ, chó không thích đứng mà chỉ thích nằm nhiều hơn.

HỆ THỐNG DA

Hệ thống da có 3 lớp: biểu bì (epiderme), chân bì (derme), mô liên kết dưới da (hypoderme). Ở chân bì có nang lông, tuyến mồ hôi, tuyến nhờn, tuyến thơm, mao quản, đầu mút thần kinh. Từ da đi ra những bó lông, cùng chung một bao lông. Mỗi bó riêng biệt có 3 (hay nhiều hơn) lông dài và to, tạo thành lớp che phủ; 6 – 12 lông nhỏ và mềm. Vào mùa xuân chó thay lông; mùa đông thay lông ít hơn; mùa hè ở chó không còn lông con; mùa thu lông bắt đầu mọc nhiều hơn. Hầu như tất cả cơ thể của chó được bao bọc bởi lớp lông dầy (ngoại trừ gương mũi, đệm ngón chân, bao dịch hoàn của con đực, âm hộ của con cái). Phía trên mắt, trên gò má, thái dương và môi trên phân bố lông dài và rất cứng.

Tuyến mồ hôi của chó chỉ có ở cuối của chân, từ đó tiết ra mồ hôi. Sự tiết mồ hôi không có ở trên tất cả bề mặt của da, vì vậy sự chênh lệch nhiệt độ của cơ thể được điều chỉnh bằng đường hô hấp (phổi) là chính và nhờ vào sự bốc hơi của dịch niêm mạc và nước bọt.

NHỮNG DẪN LIỆU SINH LÝ LÂM SÀNG CƠ BẢN

(Theo tài liệu của nước ngoài)

- Thân nhiệt (^oC): chó nhỏ 37,5 – 39,0; chó lớn 37,5 – 39,0.
- Mạch đập trong trạng thái yên tĩnh (số lần/ 1 phút): chó nhỏ 100 – 130; chó lớn 70 – 100.
- Nhịp thở của chó trong trạng thái yên tĩnh (số lần/ 1 phút): chó nhỏ 18 – 26; chó lớn 14 – 22.
- Tương quan giữa hít vào và thở ra: 1:1,6.
- Hồng cầu (triệu/mm^3): 5,5 – 8,5.
- Hàm lượng hemoglobin (đơn vị Sali): 60 – 80.
- Tiểu cầu (nghìn/mm^3): 200 – 600.
- Bạch cầu (nghìn/mm^3): 8 – 18 (?).

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

- Công thức bạch cầu (%): BC ái kiềm 1 (0 – 2); BC ái toan 3 (2 – 4); BC đa nhân trung tính 74 (60 – 82); BC đa nhân lớn 0,1 (0 – 0,3); Limpho cầu 22 (13 – 32).

NHỮNG LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA THẦN KINH CAO CẤP

Hành vi của chó , trạng thái của nó gắn liền với loại hình xác định của hoạt động thần kinh cao cấp. Điều này được tính đến không những chỉ khi chó bị rối loạn hệ thống thần kinh mà còn được tính đến khi tổ chức khám chữa bệnh cho chó với những nguyên nhân khác nhau.

Rõ ràng rằng, nguay cả trong những điều kiện bình thường, những con chó được phân biệt theo hành vi có những phản ứng rất khác nhau với những kích thích bên ngoài và quan hệ với người cũng không giống nhau.

Học thuyết I. P. Pavlov về hoạt động của thần kinh cao cấp là phương pháp cơ bản khi chia động vật ra các typ, ở đó nhất định phải xem xét sức mạnh, sự điềm tĩnh và hoạt động của các quá trình hưng phấn và ức chế. Ông đã chia ra 4 loại hình hoạt động của hệ thống thần kinh.

*** Loại hình thứ nhất:** mạnh, không cân bằng (choleric)

Chó có loại hình này thường nóng nảy, dễ xúc động, công kích, dữ dội. Chó có sự định hướng rất nhanh. Những phản xạ có điều kiện ở chúng được hình thành ngay lập tức và được phân biệt bằng sự trung thành. Trong những hoạt động quá căng thẳng của hệ thống thần kinh dễ dẫn đến loạn thần kinh chức năng.

*** Loại hình thứ hai:** mạnh, cân bằng, linh hoạt (sanguinic)

Chó có loại hình thần kinh này phản xạ điềm tĩnh với môi trường xung quanh. Phản xạ có điều kiện ở chúng hình thành nhanh chóng và giữ rất lâu, vững chắc. Những quá trình hưng phấn và ức chế có độ mạnh và linh hoạt. Chó có đặc tính của những cá thể nhiệt huyết, sôi nổi.

*** Loại hình thứ 3:** mạnh, cân bằng, ỳ (phlegmatic)

Chó có loại hình này thường lãnh đạm thờ ơ. Những quá trình hưng phấn và ức chế được phân biệt bằng độ mạnh tốt nhưng ít hoạt động.

*** Loại hình thứ 4:** yếu (melacolic)

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

Chó có loại hình này thường đa sầu, đa cảm. Những quá trình hưng phấn và ức chế yếu, thành lập phản xạ có điều kiện ở chúng rất khó. Những chó này rất nhát, thường đi vào huấn luyện một cách miễn cưỡng. Khi bị căng thẳng, ở chúng rất dễ dẫn đến sự hủy hoại của hệ thống thần kinh.
Để đánh giá chó, người ta thường dùng các từ: dữ dội, hăng hái, thiếu hăng hái, dịu dàng , lãnh đạm và ngay cả: dũng cảm, thẳng thắn, nham hiểm, giảo quyệt, hung ác, kích động; hay: tốt bụng, tin cậy, không tin tưởng, nhát gan...

CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

Việc kiểm tra có hệ thống trạng thái sinh lý lâm sàng và chẩn đoán sớm những rối loạn sức khỏe của chó có ý nghĩa quan trọng. Bệnh càng được xác định càng sớm thì việc thì việc phòng trị được kịp thời, có hiệu quả hơn. Thực hiện đúng đắn và toàn diện những nghiên cứu lâm sàng cho cơ sở soạn thảo, lựa chọn những phương pháp điều trị có hiệu quả nhất.
Phương pháp phòng trị bệnh cho chó mèo gồm các công đoạn sau:
- Chẩn đoán lâm sàng, xét nghiệm đầy đủ.
- Đánh giá các kết quả nhận được (triệu chứng).
- Làm rõ các nguyên nhân của bệnh (căn bệnh học).
- Xác định sự phát triển mang tính quy luật của bệnh (cơ chế).
- Mô tả những thay đổi bệnh lý.
- Xác định đầy đủ hình ảnh lâm sàng của bệnh, những nét đặc biệt của sự tiến triển và biến chứng của nó.
- Dự đoán tiên lượng chức năng và sự sống của nó.
- Tiến hành điều trị.
- Biện pháp phòng bệnh.

Bệnh sử

Ghi chép bệnh sử của động vật một cách cụ thể chuẩn xác, đúng phương pháp là cần thiết đối với việc nuôi dưỡng, chăm sóc và sử dụng động vật.
Bệnh sử bao gồm 4 phần:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

- Những thông tin chung về bệnh súc, với những dẫn liệu tiền sử và ghi chép thực tế.
- Kết quả tìm hiểu trạng thái lâm sàng đã xảy ra.
- Những tiến triển của bệnh với những phương pháp nghiên cứu và điều trị trước đó.
- Kết luận.

Những nghiên cứu chung

- Khám da và mô liên kết dưới da.
- Khám hạch limpho.
- Khám niêm mạc.
- Khám bộ máy vận động (cơ, xương).
- Kiểm tra thân nhiệt.
- Khám hệ thống tuần hoàn.
- Khám hệ thống hô hấp.
- Khám hệ thống tiêu hóa.
- Khám hệ thống tiết niệu.
- Khám hệ thống thần kinh.

BỆNH CARRE

- **Bệnh sài sốt chó**
- **Canin Distemper**
- **Febris catarrahalis et nervosa canum**

1. Khái niệm:

Là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus thuộc họ Paramycoviridae gây nên. Đặc trưng bằng sự phát ban của da, viêm niêm mạc đường tiêu hoá, hô hấp, niêm mạc mắt, gây sốt và tổn thương hệ thống thần kinh.

Là bệnh lây lan mạnh, tỷ lệ chết cao ở động vật ăn thịt đặc biệt là loài chó, tỷ lệ chết 60 – 90%. Con nào sống sót thì đến giai đoạn cuối thường có triệu chứng thần kinh: co giật mặc dù vẫn ăn khoẻ.

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

Khi kế phát các vi khuẩn ở đường tiêu hoá như thương hàn, tụ huyết trùng, ký sinh trùng đường ruột (giun, sán) đều làm tăng mức độ trầm trọng của bệnh.

Phân bố khắp nơi trên thế giới, gây thiệt hại lớn.

2. Tác nhân gây bệnh:

Do loại virus có thành phần là ARN đơn.

3. Dịch tễ học:

- Động vật cảm thụ: động vật ăn thịt (chó, chó sói, linh cẩu, cầy, cáo, chồn, gấu trúc, gấu,...), đặc biệt là loài chó. Chó mẫn cảm nhất là chó non (3-4 tháng tuổi).

- Chó non của những con mẹ mắc bệnh tự nhiên hay tiêm vaccin không mắc bệnh trong vòng 2 tuần đầu.

- Động vật mắc bệnh thải virus bằng nhiều đường: phân, nước tiểu, nước bọt, nước mắt, nước mũi.

- Chó ốm có thể bài tiết virus trong vòng 3 tháng.

- Các bệnh phẩm chứa virus: máu, lách, tuỷ xương, dịch phế mạc, dịch phúc mạc.

- Trong tự nhiên mầm bệnh được tàng trữ ở chó và động vật ăn thịt khác.

- *Đường lây lan:*

+ Chủ yếu là trực tiếp giữa con khoẻ và con ốm hoặc chó tiếp xúc với các dụng cụ đã chứa mầm bệnh (dụng cụ nuôi dưỡng, quần áo của những người chăm sóc, nuôi dưỡng...)

+ Đường truyền dọc: con mẹ nhiễm bệnh truyền qua màng nhau cho thai

- Mùa vụ: quanh năm, thường nhiều hơn vào mùa xuân và mùa thu.

4. Sinh bệnh học

Virus xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, tiêu hoá (qua niêm mạc), sau đó theo hệ thống lympho, từ đó theo dịch lympho vào máu đi khắp cơ thể gây nên hiện tượng: đầu tiên là sốt; viêm niêm mạc đường tiêu hoá, mắt, viêm thoái hoá ở gan, thận, não, tuỷ sống và những phần da không có lông.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

Cơ thể sinh ra kháng thể tự nhiên chống lại virus sau khi virus xâm nhập ; 9-12 ngày thì kháng thể đạt cao nhất, kéo dài 60-70 ngày.

Sức đề kháng của cơ thể giảm sút nghiêm trọng, là điều kiện để các vi khuẩn có cơ hội trỗi dậy như: thương hàn, tụ huyết trùng... làm cho quá trình bệnh lý nặng nề thêm.

Bệnh có thể cùng xảy ra với Viêm ruột truyễn nhiễm do parvovirus hay Viêm gan truyền nhiễm.

5. Triệu chứng:

Thời gian nung bệnh từ 2 – 7 ngày (đối với phòng thí nghiệm), trong tự nhiên dài hơn có thể đến 40 ngày.

a. Thể cấp tính:

- Sốt cao, nhiệt độ tăng 1-3^{0}C, sau 1-2 ngày nhiệt độ giảm đi, sốt nhẹ kéo dài. Nếu bị viêm phổi thì lại sốt cao.
- Động vật ít hoạt động hơn, run, thỉnh thoảng đứng bật dậy trong sự sợ hãi.
- Phát triển viêm cata cấp tính ở đường hô hấp:

+ Nước mũi chảy ra: lúc đầu loãng, sau đặc dần, có khi như dịch mủ

+ Con vật thở khó, thở ngắn, há mồm thở.

+ Ban đầu ho khan, sau xuất hiện có đờm, dãi, ho kéo dài liên tục, cuối cơn ho xuất hiện cơn co giật

+ Tiếp theo viêm phổi, viêm màng phổi.

- Cùng với những biểu hiện trên là: viêm kết mạc, viêm giác mạc, loét giác mạc, buồng trước nhãn cầu có dử mắt.
- Tổn thương các cơ quan ở đường tiêu hoá:

+ Giảm tính ngon miệng: mới đầu ăn ít, dần dần bỏ ăn.

+ Viêm họng nặng, viêm hạch amidan, viêm cata cấp tính đường dạ dày-ruột.

+ Nôn nhiều, nôn ra dịch màu vàng.

+ Về sau tiêu chảy, xuất hiện hợp dịch giữa phân và máu.

b. Thể á cấp tính:

- Sau thời gian sốt cao 2 – 3 ngày chuyển sốt vừa phải, gương mũi khô.

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

- Con vật trầm uất, ủ rũ, nặng nề, sợ ánh sáng.
- Tính ngon miệng giảm.
- Chảy nước mũi: thanh dịch → khô → nút lấy mũi.
- Hắt hơi, khịt mũi, ngoáy mũi bằng bàn chân.
- Nhịp thở nhanh hơn, khó khăn.
- Nghe phổi âm ran ướt.
- Gõ vùng phổi có âm đục.
- Mạch nhanh, loạn nhịp, mạch mờ nhạt.
- Mắt: + Lúc đầu chảy nước dạng thanh dịch, sau khô dần bịt mặt lại.
  + Kết mạc đỏ, sưng lên
  + Viêm giác mạc, loét giác mạc
- Dạ dày, ruột: Lúc đầu táo bón, sau phân nát dần, cuối cùng ỉa chảy, xen kẽ phân lỏng lẫn máu, nôn nhiều.
- Xuất hiện các nốt ban đỏ ở da (những nơi không có lông) bằng hạt đậu, đồng xu ở mặt trong hay ngoài của đùi, vành tai, bụng dưới, xung quanh miệng, mũi, bề mặt ướt, sáng. Bên trong chứa dịch và mủ.
- Những chỗ cong của khớp (4 chân), vùng đệm của gan bàn chân, xung quanh lỗ mũi: sừng hoá, dày lên.

c. Thể thần kinh:

- Những con mắc bệnh cấp tính nhưng không chết sẽ để lại di chứng thần kinh, con vật xuất hiện các đợt kích thích ngắn, hoảng loạn, sợ hãi, lồng lộn, giãy đạp nhiều.
- Xuất hiện hiện tượng co giật, rung cơ, cơ trên mặt co giật làm biến đổi nét mặt của con vật, co giật còn xuất hiện ở thành bụng, 4 chân.
- Thường xuất hiện những cơn động kinh định kỳ, có thể dẫn đến liệt nhẹ hay liệt (thường ở 2 chân sau).
- Liệt cơ vòng bàng quang, trực tràng, bài tiết phân, nước tiểu tuỳ tiện.
- Liệt thần kinh mặt.

6. Chẩn đoán:

- Căn cứ vào biểu hiện dịch tễ học, triệu chứng lâm sàng.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

- Dùng kít chẩn đoán (?)

7. Điều trị:

- Kháng huyết thanh (nếu có).
- Chống nôn: Atropin sulfat 0,1%, 1ml/10kgP, tiêm nhiều lần: 6h/lần tiêm.
- Chất điện giải: cho uống glucoza + chất điện giải, nếu nôn nhiều không cho uống điện giải nhưng vẫn cho uống glucoza.
- Truyền dịch: Glucoza 5%

  NaCl 0,9%

  Ringer lactate

  Tốc độ truyền chậm, con yếu: 60 – 80 giọt/phút.
- Dùng kháng sinh: gentamycin, kanamycin, oflocacin, enroflocacin,…
- Hạ sốt: paracetamol, anagil.
- Vitamin: K, C, nhóm B.
- Trợ tim: cafein, camphora, adrenalin.
- Hộ lý: giữ ấm cho con vật.

8. Phòng bệnh

- Phòng bệnh bằng vệ sinh, chăm sóc, nuôi dưỡng.
- Tiêm phòng bằng vaccin

+ Vaccin Vanguard Plus 5, phòng các bệnh: Carre, VRTN do parvovirus, ho cũi chó (Parainfluenza virus), viêm gan truyền nhiễm. Liều 1ml/ 1 chó. Lần 1 chó từ 6 tuần tuổi trở lên. Mũi tiêm thứ 2,3 cách mũi tiêm trước 3 tuần. Hàng năm tiêm nhắc lại.

+ Vaccin Vanguard Plus 5/CV-L (gồm vaccin đông khô: Vanguard HTLP 5/CV-L và vaccin dạng lỏng: First Dose CV), phòng các bệnh: Carre, VRTN do parvovirus, viêm gan truyền nhiễm, xoắn khuẩn (2 chủng: L. Canicola và L. Icterohaemorrhagiae), ho cũi chó, bệnh do coronavirus.

Liều dùng 1ml/ 1 chó. Lần 1 chó từ 6 tuần tuổi trở lên. Mũi tiêm thứ 2, 3 cách mũi tiêm trước 3 tuần. Hàng năm tiêm nhắc lại với liều vaccin đông khô.

+ Vaccin Tetradog (gồm vaccin đông khô Trivirovax và vaccin dạng lỏng Leptospia), phòng các bệnh: Carre, VRTN do parvovirus, viêm gan truyền nhiễm

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

và xoắn khuẩn (2 chủng). Liều dùng 1ml/ 1 chó. Mũi tiêm thứ nhất kể từ khi chó 7 tuần tuổi. Mũi tiêm thứ hai sau đó 3-5 tuần, không nên tiêm sau 12 tuần tuổi. Hàng năm tiêm nhắc lại.

+ Vaccin Hexadog, phòng các bệnh: Carre, VRTN do parvovirus, viêm gan truyền nhiễm, xoắn khuẩn (2 chủng) và bệnh dại. Liều 1ml/ 1 chó. Tiêm lần đầu lúc chó 3 tháng tuổi. Hàng năm tiêm nhắc lại.

+ Vaccin Erican DHPPI 2, phòng các bệnh: Carre, VRTN do parvovirus, viêm gan truyền nhiễm, ho cũi chó. Liều tiêm 1ml/ 1chó. Tiêm lần đầu khi chó 7 tuần tuổi, tiêm lần hai cách mũi đầu từ 3 – 5 tuần, hàng năm tiêm nhắc lại.

BỆNH XOẮN KHUẨN

● Leptospirosis

1. Giới thiệu chung

- Là bệnh truyền nhiễm chung cho nhiều loài súc vật và người
- Đặc trưng của bệnh là sốt định kỳ, rối loạn tiêu hóa, viêm gan, viêm thận, ở con cái có thể xảy thai
- Xoắn khuẩn tác động phá hủy tế bào máu dẫn đến hiện tượng vàng da, vàng niêm mạc; nước tiểu màu vàng hoặc đái ra máu

2. Truyền nhiễm học

2.1. Loài vật mắc bệnh

– Trong thiên nhiên, xoắn khuẩn gây bệnh cho nhiều loài súc vật và người

+ L. gây bệnh cho bò, chó nhiều nhất; sau đó đến ngựa, cừu, dê, lợn, mèo

+ Trong loài dã thú, báo dễ mắc; bệnh có tính chất "nguồn dịch thiên nhiên"

+ Người mắc bệnh do 2 chủng L. icterohaemorrhagiae và L. grippotyphosa, mang tính nghề nghiệp rõ : công nhân làm vệ sinh cống rãnh, công nhân chăn nuôi, cán bộ địa chất, lâm nghiệp hay mắc bệnh

+ Chuột được coi là ổ chứa thường xuyên, luôn mang và thải mầm bệnh→ không chỉ là NTTG mà còn được coi là nguồn bệnh.

–Trong phòng thí nghiệm: thường dùng chuột lang làm đvtn.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

+ Tiêm vào xoang bụng hoặc dưới da.

+ Sau khi tiêm 2-3 ngày chuột sốt, nhiệt độ có thể lên cao đến 40,5 – 41,5°C trong 3 ngày

+ Con vật gầy.

+ Niêm mạc mắt và da có màu vàng, xuất huyết.

+ Sau 6 – 12 ngày thân nhiệt hạ, chuột chết.

+ Mổ khám: vàng da, niêm mạc, phủ tạng, gan sưng to. Lấy bệnh phẩm (nước xoang bụng, máu tim, gan, thận …) kiểm tra sẽ tìm thấy xoắn khuẩn.

+ Ngoài ra có thể dùng thỏ, chuột bạch.

2.2. Dịch tễ học

- Lây lan

+ Xoắn khuẩn có khả năng xâm nhập qua chỗ xây xát của da, niêm mạc.

+ Xâm nhập qua da và niêm mạc lành lặn.

+ Lây qua đường tiêu hóa do thức ăn, nước uống nhiễm mầm bệnh (từ nước tiểu).

+ Lây qua đường sinh dục.

- Mùa vụ : bệnh xảy ra quanh năm nhưng thường tập trung vào mùa mưa, bão lụt

2.3. Cơ chế sinh bệnh :

– Sau khi xâm nhập vào cơ thể, L vào hệ thống tuần hoàn sẽ sinh sản, phát triển, tiết độc tố phá hủy hồng cầu làm cho niêm mạc nhợt nhạt, con vật thiếu máu, đái ra máu hoặc đái ra huyết sắc tố.

– Độc tố phá hủy thành mạch quản dẫn đến hiện tượng xuất huyết, thấm tương dịch gây phù nề, thủy thũng ở tổ chức liên kết dưới da

– Từ máu, XK đến gan, thận.

+ Ở thận: gây viêm bể thận và niệu quản→ con vật đái ra máu.

+ Ở gan: gây viêm gan, khả năng tiết mật bị hạn chế→ túi mật teo, dịch mật đặc, sánh.

– Trong thời gian XK ở hệ thống tuần hoàn, con vật sốt. Khi đến thận, con vật không sốt. Nhưng khi từ niệu quản vào hệ tuần hoàn, con vật sốt → vật sốt có tính định kỳ.

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

3. Triệu chứng

– Thường mắc bệnh do L. canicola và L. icterohaemorrhagiae, ngoài ra có thể phân lập được L. pomona và L. grippotyphosa.

– Chó mắc bệnh ở mọi lứa tuổi.

– Thời gian ủ bệnh từ 4 – 12 ngày.

– Con vật sốt, bỏ ăn, lười vận động.

– Nôn mửa, ỉa chảy, viêm loét niêm mạc miệng.

– Trường hợp bệnh nặng, con vật có chứng hoàng đản do gan bị tổn thương ở các mức độ khác nhau.

– Viêm màng não, viêm vùng hầu họng.

– Hiện tượng sảy thai có thể xảy ra.

– Bệnh tiến triển 15 – 20 – 30 ngày, tỷ lệ chết lên đến 100%.

4. Bệnh tích

- Do bệnh tiến triển ở thể mạn tính nên xác chết thường gầy, thịt có mùi khét.
- Mô liên kết dưới da thường thấm dịch nhớt, keo nhày dễ đông → thịt ướt.
- Hầu hết mỡ ở mô liên kết dưới da và các cơ quan bộ phận đều có màu vàng.
- Túi mật bị teo, dịch mật sánh, quánh, đặc, thành túi mật dầy lên.
- Tích nhiều nước vàng và thường dễ đông trong các xoang : xoang ngực, xoang bụng, x. bao tim.
- Viêm gan: gan sưng, màu vàng hoặc có màu đất thó (trắng xám). Trên bề mặt gan có các đám hoặc điểm hoại tử.
- Thận: viêm, sưng, bể thận và ống dẫn niệu chứa nước tiểu đỏ. Trên bề mặt thận có các điểm xuất huyết hoặc hoại tử.
- Bàng quang : viêm niêm mạc bàng quang, bên trong có chứa nhiều nước tiểu màu đỏ.

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán dựa vào DTH và triệu chứng

– Loài vật mắc bệnh.

– Lứa tuổi.

– Mùa vụ : thường xảy ra vào mùa mưa, bão lụt.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

– Tỷ lệ ốm và nhiễm bệnh cao, tỷ lệ chết không cao.

– Bệnh thường xảy ra ở những vùng ngập lụt.

5.2. Chẩn đoán vi khuẩn học

– Lấy bệnh phẩm : tùy theo thời gian và thể bệnh, có thể lấy các bệnh phẩm khác nhau.

+ Sốt trong tuần lễ đầu thì lấy máu.

+ Sốt trên 10 ngày lấy nước tiểu.

+ Nếu gia súc chết lấy gan, thận, óc.

- Phương pháp chẩn đoán VKH chỉ có ý nghĩa phát hiện trong cơ thể có hay không có mầm bệnh mà không phát hiện được chủng nào.

5.3. Chẩn đoán huyết thanh học

– Đây là phương pháp chẩn đoán quan trọng, phát hiện được chủng gây bệnh và tiến triển của bệnh.

– Có thể dùng nhiều phản ứng khác nhau như:

+ Phản ứng ngưng kết hồng cầu.

+ Phản ứng kết hợp bổ thể.

+ Phản ứng kháng thể huỳnh quang.

+ Phản ứng ngưng kết - *thông dụng nhất và có giá trị hơn cả.*

Phản ứng vi ngưng kết với kháng nguyên sống trên phiến kính.

Phản ứng ngưng kết với kháng nguyên chết.

6. Điều trị

- Nguyên tắc: dùng kháng huyết thanh tốt nhất, nhưng yêu cầu can thiệp sớm, đúng chủng gây bệnh.

– Dùng kháng sinh: oxytetracyclin, ampicillin, amoxycilin, lincomycin, streptomycin. Kháng sinh nên dùng liều cao với liệu trình kéo dài, tiêm tiếp 3 ngày kể từ khi hết triệu chứng. Dùng amtyo của công ty Hanvet có hiệu quả tích cực.

- Thuốc trợ sức, trợ lực.

- Chăm sóc nuôi dưỡng tốt

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

7. Phòng bệnh

- Vệ sinh phòng bệnh

+ Chăm sóc, nuôi dương tốt, đảm bảo vệ sinh chuồng trại.

+ Thường xuyên tiêu diệt chuột.

+ Đảm bảo phương tiện phòng hộ cho những người nguy cơ mắc bệnh cao.

Khi dịch đã xảy ra : xử lý thức ăn, nước uống, xác chết.

– Nếu có hiện tượng hoàng đản + các bệnh tích khác, có mùi khét → hủy

– Nếu không mùi: để 24 giờ, nếu mất màu thì luộc chín; không mất màu → hủy

- Vaccin phòng bệnh

Về nguyên tắc, vaccin phòng bệnh cần chứa chủng leptospira phù hợp với chủng nhiễm trên chó của địa phương. Trên thị trường có thể có nhiều loại, thay đổi tùy nơi sản xuất. Có loại chỉ dùng để phòng bệnh xoắn khuẩn, có loại phòng các bệnh khác kết hợp với phòng bệnh xoắn khuẩn (đa giá).

+ Vaccin vô hoạt gồm 6 chủng Leptospira. (tên là gì?)

- Lợn: 3 – 5 ml/ 1 con.
- Trâu , bò: 5 ml/ 1 con.

Miễn dịch kéo dài: 6 tháng.

+Vaccin Farrowsure (xem lại tên?) gồm 5 chủng Leptospira (L. canicola, L.grippotyphosa, L. hardjo, L. icterohaemorrhagiae, L. pomona) + DL(?)+Parvovirus.

- Lợn: 5ml / con.

Tiêm 1 lần trước khi phối 14 – 21 ngày

- Định kỳ 6 tháng tiêm nhắc lại.

+ Xem phần phòng bệnh carre.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

BỆNH VIÊM RUỘT TRUYỀN NHIỄM DO PARVOVIRUS

● Parvovirus enteritis canum

● Bệnh Par-vô

● Bệnh do parvovirus trên chó

1. Khái niệm

Bệnh lây rất cao ở chó, chủ yếu ở chó con. Bệnh được đặc trưng bằng những biểu hiện:

- Chất nôn ra giống mật và tiêu chảy.
- Viêm chảy máu đường dạ dày-ruột.
- Sự mất nước của cơ thể.
- Tổn thương cơ tim.
- Sự chết nhanh chóng của động vật mắc bệnh.

2. Căn bệnh

- Do virus thuộc họ Parvoviridae, giống Parvovirus ở chó, type 2 (CPV-2).
- Kích thước 18-24 nm, nhân chứa ADN đơn dòng thẳng, không có vỏ bọc.
- Sức đề kháng: bền vững với những tác động vật lý, hóa học. Chịu đựng được sự đun nóng ở 60^0C trong vòng 1 giờ, không mất hoạt tính khi xử lý bằng ether, chloroform, ngay cả ở môi trường có pH = 3. Tồn tại lâu trong điều kiện tự nhiên.

3. Dịch tễ

- Nguồn gốc tác nhân truyền bệnh: những con chó mắc bệnh và vật dụng mang virus. Virus được bài tiết ra môi trường bên ngoài với phân và chất nôn.
- Tất cả các giống chó đều mẫm cảm.
- Chó non từ 1 – 5 tháng tuổi dễ mắc nhất.

4. Đường xâm nhập:

- Xâm nhập qua miệng từ những con chó bệnh.
- Mùa vụ phát bệnh: không có mùa rõ ràng, thường phát triển vào mùa xuân, đầu hè. Thời tiết ấm, ẩm thuận lợi cho virus tồn tại và phát triển.
- Bệnh phát triển khi có nhiều chó con ra đời, những đợt tiêm phòng.

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

5. Sinh bệnh học

- Chó con 4 – 5 tuần tuổi dễ bị xâm nhập gây viêm cơ tim.
- Kháng thể đặc hiệu xuất hiện sau 1 vài tuần, cho nên khả năng đáp ứng miễn dịch không cao.

6. Triệu chứng

- Thời gian nung bệnh, trong tự nhiên kéo dài đến 10 ngày, trong thí nghiệm từ 3 – 4 ngày.
- Bệnh thường xảy ra ở thể cấp tính: xuất hiện đột ngột với những triệu chứng của viêm dạ dày-ruột.
- Biểu hiện đầu tiên thường là nôn, quan sát được suốt đến khi khỏi bệnh hay chết. Lúc đầu nôn ra chất chứa trong dạ dày → nhày đặc với sắc thái vàng. Con vật nôn ngay sau khi ăn uống (khi điều trị không được chỉ định thuốc uồng vì dễ bị nôn ra ngoài). Nôn được nhắc lại với quãng cách 30 – 40 phút/ lần.
- Tiêu chảy xuất hiện sau nôn 1 – 5 ngày: lúc đầu phân màu tro xám, hay vàng lẫn máu; về sau như nước lẫn máu, có mùi tanh khắm, bết lại phần sau của cơ thể làm con vật rất hôi hám.
- Nôn + ỉa chảy làm con vật mất nước → khát nước. *Đây là dấu hiệu phân biệt với bệnh khác: care, viêm gan do virus...*
- Ở những động vật cá biệt, sau khi xuất hiện nôn và tiêu chảy, phát triển những tổn thương ở đường hô hấp: viêm phế quản, viêm phổi…làm con vật có biểu hiện sốt 41^0C, chó lớn sốt nhẹ hơn.
- Động vật bỏ ăn: lúc đầu ăn ít, sau đó bỏ ăn hoàn toàn. Con vật thường bị sút cân, gầy dộc, da mất đàn tính, lông xơ xác, mắt trũng sâu.
- Bệnh súc với trạng thái lạnh lùng, rên rỉ.
- Khi thân nhiệt hạ thấp đồng thời với sự xấu đi trạng thái chung của động vật cần phải được xem xét như dấu hiệu lâm sàng không thuận lợi. Tiên lượng xấu, lúc này con vật có thể chết, chó con có thể chết nhanh chóng chỉ 1 – 3 ngày sau khi mắc bệnh. Tỷ lệ chết cao từ 40 – 50%

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

- Một số trường hợp chó non từ 3 tuần tới 7 tháng tuổi, bệnh thường xảy ra ở thể rối loạn chức năng đường tiêu hóa + tổn thương cơ tim gọi là thể tim ruột, chó thường chết nhanh chóng trong vòng 24h, tỷ lệ chết 70%.
- Sờ vào thành bụng con vật đau, nhu động ruột tăng
- Khi xét nghiệm máu: bạch cầu giảm

4 – 5 ngày sau mắc bệnh: còn 2300/1mm^3 (bình thường 6 – 12000/1 mm^3)(?).

7. Bệnh tích:

- Chủ yếu ở ruột: viêm xuất huyết ở niêm mạc ruột non và ruột già. Đôi khi ghi nhận được sự bào mòn ở ruột.
- Hạch lympho ở màng treo ruột sưng lên, xuất huyết.
- Ở những động vật riêng biệt, quan sát được hiện tượng phù phổi và viêm cơ tim.

8. Chẩn đoán

Chẩn đoán sơ bộ có thể đạt được dựa trên cơ sở những dẫn liệu về dịch tễ học, triệu chứng lâm sàng và hình thái bệnh tích.

- Phát tán rộng.
- Tỷ lệ mắc bệnh cao trong số chó non.
- Nôn nhiều.
- Phân loãng lẫn máu, đôi khi có ống niêm mạc ruột.
- Giảm bach cầu.
- Viêm xuất huyết niên mạc ruột.
- Hạch limpho màng treo ruột sưng, xuất huyết.

9. Điều trị

Tương tự như điều trị bệnh Carre.

- Huyết thanh đa giá: phải dùng ngay từ đầu.
- Chống nôn, chống mất nước, chống mất chất điện giải.
- Chống nhiễm trùng cơ hội.
- Tăng sức đề kháng.
- Giữ ấm.

10. Phòng bệnh

Xem phần phòng bệnh Carre.

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

BỆNH VIÊM GAN TRUYỀN NHIỄM TRÊN CHÓ

● Hepatitis infectius canine

Là bệnh truyền nhiễm cấp tính, đặc trưng bằng sự sốt cao, viêm cata niêm mạc đường hô hấp và đường ruột, tổn thương thận và hệ thống thần kinh trung ương. Bệnh có khắp nơi trên thế giới. Ở nước ta chưa có những công bố chính thức. Nghi ngờ (?).

1. Căn bệnh

Virus chứa AND. Họ Adenoviridae. Giống Mastadenovirus.

Virus hướng thần kinh và gan.

Virus bền vững với những tác nhân vật lý khác nhau, khi đông lạnh, lúc sấy khô và ở trong dung dịch glycerin 50%.

Ở nhiệt độ phòng virus sống tới 1 năm.

Trong tự nhiên nó được bảo tồn trên 2 năm.

Ở 4^0C virus bảo tồn hoạt tính hơn 9 tháng.

Ở 50^0C " 150 phút.

Ơ 100^0C " 1 phút.

Virus bền vững với ether, chloroform, methanol.

Virus không bền vững với: formalin, phenol, vôi mới tôi. Những chất trên diệt nó trong vòng 30 phút.

2. Dịch tễ

- Loài vật mắc bệnh: trong tự nhiên chó mọi lứa tuổi, tất cả các giống đều có thể mắc bệnh, nhưng chó non 1,5 – 6 tháng tuổi thường cảm nhiễm hơn cả. Chó già trên 3 năm ít mắc mắc bệnh. Cáo, chó sói, chó núi cũng mắc bệnh. Một vài giống khỉ, chuột và người có thể mang virus (thể ẩn).
- Nguồn virus chính: những con con chó dương bệnh và mang virus. Từ những con chó đó virus được bài tiết ra ngoài qua: phân, nước tiểu, dịch mũi, chất tiết của kết mạc.
- Nét đặc biệt dịch tễ học của Viêm gan virus ở chó là sự mang virus tiếp tục, lâu dài ở động vật khỏi bệnh tới nhiều năm sau.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

- Nguồn dự trữ tự nhiên: thú hoang, chó lang thang.

- Virus xâm nhập chủ yếu là đường tiêu hóa, lây lan trực tiếp từ những chó nhốt chung hoặc gián tiếp qua thức ăn, nước uống bị nhiễm, qua dụng cụ chăm sóc, cầm cột…

- Phát tán bệnh khi tiêm phòng đại trà không quán triệt các nguyên tắc vô trùng, khử trùng.

- Có những dẫn liệu về những con chó cái mang bệnh nhiều năm, lây sang những con của nó; và lây sang cả những con chó đực tiếp xúc với chúng, nhất là khi giao phối.

- Thời gian phát bệnh: Bệnh phát ra quanh năm và liên quan chủ yếu với sự bột phát của tiến triển mãn tính và tiềm tàng của bệnh dưới tác động của những nguyên nhân không thuận lợi nào đó.

- Sự quá lạnh, quá nóng, cho ăn uống không đầy đủ, nhiễm trùng, bệnh giun sán và những tác động không thuận lợi khác hoạt hóa tiến triển tiềm tang của Viêm gan truyền nhiễm, dẫn đến sự xuất hiện những triệu chứng lâm sàng của bệnh.

- Tỉ lệ chết: 20%.

- Viêm gan truyền nhiễm thường ghép với các bệnh khác: Carre, Salmolenosis, Colibacterios… dẫn đến sự chết nhanh của động vật và gây khó khăn cho việc chẩn đoán.

- Kháng thể chống virus xuất hiện vào ngày thứ 15 – 21 sau khi mắc bệnh; đạt tối đa vào ngày thứ 30, kéo dài suốt đời.

3. Sinh bệnh học

(Tham khảo tài liệu của Trần Thanh Phong)

Virus CAV-1 qua đường miệng, tiêu hóa xâm nhập mô bào hầu hết các cơ quan cơ thể của chó, dù chưa phát bệnh (ủ bệnh) nhưng thời gian nhiễm CAV-1 này đã có thể lây truyền sang chó khác qua các chất bài tiết : phân, nước tiểu và rớt dãi...Những con chó may mắn khỏi bệnh vẫn mang virus tới 9 tháng sau.

4. Triệu chứng:

- Thời gian nung bệnh tự nhiên 3-9 ngày, gây bệnh thực nghiệm 2-6 ngày

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

** Thể cấp tính*

- Sau thời gian nung bệnh xuất hiện các triệu chứng: ức chế, uể oải, ủ rũ, không ăn, khát nước, thường nôn ra các hỗn hợp dịch mật màu vàng.
- Viêm hạch amidan.
- Viêm giác mạc: lúc đầu nước mắt loãng sau có dử; mắt có màng, đục như cùi nhãn ở 1 mắt hay cả hai mắt (đây là một trong những triệu chứng điển hình để chẩn đoán).
- Con vật ít hoạt động, đi lại chệnh choạng, không vững, nằm nhiều.
- Sốt: lúc sốt lúc không. Khi sốt quan sát được sự rối loạn của hoạt động tim mạch. Nhịp tim 90-110 lần/phút hoặc cao hơn nữa.
- Biểu hiện tiêu chảy: phân nửa rắn nửa nát → nát có vệt máu tươi.
- Niêm mạc màu vàng đặc biệt là niêm mạc mắt, lưỡi.
- Đau vùng gan, co người lại rên rỉ.
- Có biểu hiện co giật hoặc liệt chân sau.
- Xét nghiệm máu: lúc đầu bạch cầu giảm (2-3 nghìn/ $1mm^3$), về sau tăng (30-35 nghìn/ $1mm^3$).

** Thể mạn tính*

Triệu chứng, bệnh tích xảy ra đột ngột, không xác định.

- Sốt nhẹ, kéo dài, không dứt cơn.
- Con vật ngày càng gầy còm, ốm yếu, thiếu máu.
- Niêm mạc nhợt nhạt.
- Mô liên kết dưới da bị phù nề.
- Viêm giác mạc lâu không khỏi.
- Viêm dạ dày, ruột.
- Phân lúc nát có vệt máu.
- Chó cái chửa thường hay sảy thai, đẻ non hoặc con chết ngay sau khi đẻ

** Thể tiềm tàng (ẩn)*

Chó ốm bài tiết virus nhưng không có triệu chứng của bệnh, có thể bùng phát khi gặp những điều kiện không thuận lợi làm giảm sức đề kháng của con bệnh.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

5. Bệnh tích

- Mức độ nặng nhẹ khác nhau phụ thuộc vào thời gian mắc bệnh.
- Kết mạc xung huyết màu vàng
- Niêm mạc nhợt nhạt, có điểm lấm tấm xuất huyết.
- Hạch amidan viêm, phù
- Bệnh tích đặc trưng ở gan: sưng to, màu nâu hay đỏ sấm, trên bề mặt phủ lớp fibrin mỏng, thành túi mật bị phù, tích dịch ở xoang bụng, dịch trong suốt hay màu vàng lẫn máu.
- Lách sưng to
- Dạ dày chỉ có chất nhày, màu nâu đậm (màu của máu lâu ngày). Niêm mạc dạ dày xuất huyết, có những lớp nhầy dày đặc
- Thận sưng to, màng thận dễ bóc. Nhu mô thận xuất huyết điểm hoặc xuất huyết vạch.

6. Chẩn đoán:

Phân tích số liệu về dịch tễ học, triệu chứng lâm sàng, biến đổi bệnh lý.

7. Điều trị:

- Không cho ăn thức ăn chứa mỡ.
- Dùng vitamin nhóm B, đặc biệt B12 làm giảm sự thấm nhiễm mỡ, tăng hoạt động của chức năng gan.
- Vitamin C: trộn vào thức ăn 10 – 15 ngày, tạo điều kiện cho quá trình tổng hợp glycogen ở gan, tăng cao chức năng giải độc của gan, đặc biệt là tăng sự tái sinh của tế bào gan.
- Bù nước, cân bằng điện giải: truyền dung dịch đường glucose, Ringer lactate…
- Dùng kháng sinh chống nhiễm trùng kế phát.

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

BỆNH GIẢM BẠCH CẦU MÈO

● Feline infectious intertis

1. Khái niệm

Bệnh giảm bạch cầu mèo là 1 bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, có tính lây truyền mạnh ở cả mèo nhà và mèo hoang.

Đặc điểm của bệnh là: Xảy ra bất thình lình, sốt, bỏ ăn, nôn mửa, mất nước, suy nhược, số lượng bạch cầu giảm, và tỷ lệ chết cao.

2. Nguyên nhân

Do virus ADN có tên: Feline panvovirus

- Virus đề kháng cao với ether, cloroform, acid, cồn và nhiệt độ (ở 56^0C chết trong 30 phút)

- Nhạy cảm với các chất tẩy có clo. (ví dụ: cloramin B, T).

- Trong thiên nhiên các virus tồn tại thời gian lâu, nhất là môi trường nóng ẩm, khả năng gây bệnh hàng tháng có khi hơn 1 năm.

- Virus thải ra qua nước bọt, nước tiểu, phân của những con vật bệnh. Tiếp tục thải virus sau khi khỏi bệnh nhiều tháng.

- Tất cả các thành viên của họ mèo (felidae) đều nhiễm virus: mèo nhà, mèo rừng, sư tử, báo. Xảy ra ở mọi lứa tuổi, chủ yếu ở mèo con. Ở những đàn nhạy cảm, bệnh có thể phát ra ở 100% số cá thể. Ở những đàn khác chỉ có một số con bị ảnh hưởng. Như vậy đã có ảnh hưởng đáng kể từ đàn này sang đàn khác hay từ đợt dịch này sang đợt dịch khác.

- Bệnh có thể xảy ra quanh năm, ảnh hưởng theo mùa, theo khu vực địa lý.

- Con đường lây nhiễm

+ Trực tiếp: do tiếp xúc giữa mèo khoẻ và mèo bệnh hoặc tiếp xúc với chất tiết của mèo bệnh như phân, nước tiểu, nước bọt, chất nôn

+ Trong giai đoạn phát triển cấp tính của bệnh, bọ chét có thể truyền virus từ động vật mắc bệnh sang động vật nhạy cảm.

+ Do tiếp xúc với dụng cụ chứa virus: dụng cụ cho ăn, tấm đệm cho mèo nằm, cũi nhốt mèo, ngay cả người chăm sóc, nuôi dưỡng, chữa bệnh.

3. Sinh bệnh học

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

- Virus đi vào theo đường hô hấp, đường miệng vào hạch lympho ở miệng, hầu, ruột.

- Sau 24h sau xuất hiện trong máu, vào khắp các mô bào trong cơ thể. Ảnh hưởng nghiêm trọng: hạch lympho, tuỷ xương, tuyến ức, tiểu não nên làm giảm bạch cầu.

- Trong máu xuất hiện kháng thể, làm virus trong máu giảm dần.

4. Triệu chứng

- Thời gian nung bệnh từ 2 – 10 ngày

- Biểu hiện triệu chứng lâm sàng thể hiện không giống nhau, có thể thay đổi lớn tùy theo trường hợp mắc bệnh.

a. Thể quá cấp tính

- Bệnh xảy ra nhanh, con vật suy nhược nghiêm trọng.

- Đau vùng bụng (quay đầu về phía bụng, ấn vào con vật kêu).

- Thân nhiệt hạ, chết sau khi hạ thân nhiệt 1 ngày (thường nghi ngờ mèo bị trúng độc).

b. Thể cấp tính

- Là thể điển hình nhất.

- Sốt 39,5^{0}C hoặc cao hơn

- Bỏ ăn, nôn mửa, tiêu chảy, suy nhược trầm trọng (xảy ra trong 1-2 ngày). Nếu tiếp tục nôn và tiêu chảy thì con vật bị mất nước nghiêm trọng, mất chất điện giải, khát nước.

- Đầu co vào gập vào giữa hai chân trước (điển hình).

- Lông thô, xù xì.

- Da mất đàn tính.

- Mắt chũng vào, nhất là góc ở gần mũi)

- Khám vùng bụng con vật đau.

- Đường tiêu hoá có nhiều dịch và hơi.

- Bị nặng hơn: thân nhiệt giảm dưới mức bình thường. Con vật hôn mê, thường chết 1-2h sau khi hạ thân nhiệt.

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

- Tỷ lệ chết thay đổi tuỳ theo đợt dịch: 25-75%. Chết xảy ra trong vòng 5 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên.

- Nếu không chết và không nhiễm các bệnh kế phát thì sự phục hồi sau đó tương đối nhanh, hồi phục hoàn toàn trong 2 tuần.

c. Thể á cấp tính

- Mức độ bệnh nhẹ hơn nhiều.
- Nhiệt độ của cơ thể tăng nhưng không đáng kể.
- Con vật ăn ít.
- Bạch cầu giảm nhẹ.

d. Thể cận lâm sàng (thể ẩn)

Nhiều mèo mắc bệnh ở mức độ cận lâm sàng mà không có biểu hiện triệu chứng nào cả. Chỉ phát hiện được nhờ các phương pháp chẩn đoán huyết thanh học hay chẩn đoán virus học.

e. Triệu chứng của mèo con mắc bệnh trong tử cung không nhận thấy được ngay sau khi sinh, chỉ nhận ra được trước cái chết đột ngột của chúng hoặc khi mèo con được 2 tuần tuổi có biểu hiện rối loạn vận động:

- Co giật không chủ ý của đầu.
- Sự lắc lư của cơ thể.
- Mèo cố gắng đi nhưng thường bị ngã nhào, cuộn tròn hay lăn lộn.

Nếu những mèo này tự lấy được thức ăn, được chăm sóc tốt; chúng vẫn sống tuy nhiên sự co giật, mất điều khiển vận động vẫn còn; khi chúng lớn lên, có giảm nhưng không đáng kể.

5. Điều trị

Mục tiêu chính là giữ cho mèo mắc bệnh còn sống cho đến khi khả năng phòng vệ tự nhiên của nó có thể tự đảm nhận được.

Kháng thể xuất hiện vào 3 – 4 ngày sau khi thấy triệu chứng đầu tiên của bệnh; tiếp theo 2 – 3 ngày sau sự tăng bạch cầu trở lại có thể xảy ra. Do đó, nếu mèo được điều trị, chăm sóc tốt, giúp mèo qua được 5 – 7 ngày sau cơn bệnh thì cơ hội hồi phục thường rất tốt.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

- Chống nôn: Atropin sulfat 0,1%, liều 0,1 ml/ 1kg TT. Lúc nôn nhiều 2 – 3h/ lần, sau 6h/ lần.
- Chống ỉa chảy: dùng tanin hay nước lá chát (nước chè, búp ổi, lá sim...).
- Đề phòng nhiễm trùng kế phát: kháng sinh hay sulfamid.
- Bù nước, điện giải (uống hoặc truyền).
- Không nên dùng cafein natri benzoat vì làm con vật chết nhanh (kinh nghiệm).

6. Phòng bệnh

Vaccin Leucorifelin, của hãng Merial sản xuất. Là loại vaccin đa giá, phòng bệnh giảm bạch cầu mèo, bệnh ở đường hô hấp do virus herpes và bệnh viêm mũi khí quản truyền nhiễm. Liều dùng 1ml/ 1mèo, tiêm dưới da. Lần thứ nhất tiêm lúc mèo 8 tuần tuổi; lần thứ hai cách lần tiêm thứ nhất 4 tuần; tiêm nhắc lại hàng năm. Không sử dụng cho mèo mang thai và các giống mèo nhạy cảm với virus giảm bạch cầu mèo. Tác dụng phụ: có thể nổi nốt nhỏ nơi vết tiêm. Ngoại lệ có thể gây trạng thái quá mẫn → điều trị theo triệu chứng.

BỆNH RICKETTSIA

● Rickettsiosis

- Rickettsia ký sinh bắt buộc trong tế bào. Bắt màu Gram(-). Kích thước lớn hơn virus, nhỏ hơn vi khuẩn. Tế bào có hình thái biến hóa: que, sợi, cầu, song cầu. Do ký sinh bắt buộc nên Rickettsia không phát triển trên các môi trường nhân tạo, phải nuôi cấy trên các môi trường mô bào sống: phôi gà, tinh hoàn chuột lang.
- Sức đề kháng yếu với nhiệt độ cao: ở 80^0C chết sau 1 phút; ở 100^0C chết sau 3º giây. Ngược lại ở nhiệt độ lạnh và đông khô chúng sống khá lâu.
- Mẫn cảm với môi trường acid, formalin và các chất sát trùng khác.

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

- Vật chủ của Rickettsia là các động vật chân đốt: ve, bọ, rận... Các động vật này truyền mầm bệnh qua người và động vật khác, gây sốt phát ban, sốt Q ở người.

- Ở nước ta, nghi ngờ sự có mặt của Rickettsia. Những đàn chó nhập nội có nguy cơ mắc bệnh cao.

- Ricketsia có 3 giốn khác nhau: trong đó Ehirichia canis gây bệnh phổ biến, thường nằm trong bào tương của bạch cầu. (hai giống còn lại ít gặp hơn)

- Truyền bệnh là do ve Rhipicephalus sanguineus. Ve mang mầm bệnh đốt, hút chích máu chó mèo và truyền bệnh

- Khi bị nhiễm Ehirichia canis thời gian gian nung bệnh:

+ Theo Nguyễn Vĩnh Phước: 3 – 5 ngày

+ Các tác giả khác: 1 – 21 ngày

- Biểu hiện của bệnh: đầu tiên chó sốt cao từ 40 – 41^{0}C, ủ rũ, mệt mỏi, kém ăn, bỏ ăn, sụt cân, thở khó (thở ngắn hơn), thiếu máu (chảy máu ở niêm mạc).

Chó mắc bệnh nhẹ nếu chăm sóc và nuôi dưỡng tốt thì con vật sẽ khỏi bệnh. Mặc dù mầm bệnh vẫn tồn tại nhưng các triệu chứng không xảy ra, con vật trong tình trạng mang bệnh. Có những điều kiện làm sức đề kháng của con vật giảm sút thì bệnh lại phát ra.

- Khi bệnh tiến triển nặng: con vật sốt cao theo từng đợt (tái đi tái lại nhiều lần); ở mũi và tai chảy nước, có thể lẫn máu, mủ; hơi thở có mùi mùi hôi thối do niêm mạc miệng bị phồng, hình thành các nốt loét.

Chảy máu mũi ồ ạt, làm mất máu nhiều, thiếu máu ngày càng nặng nề. Con vật gầy còm, ốm yếu, niêm mạc nhợt nhạt (trắng bệnh) phù ở các mô liên kết ở các vùng xa tim (thuỷ thũng), thường ở 4 chân hoặc bao quy đầu.

Xuất huyết lấm tấm ở các vùng da mỏng: nách, bẹn hay ở niêm mạc mắt, mũi.

Liệt hoặc liệt nhẹ 2 chân sau, co giật.

Dạ dày và ruột bị viêm, xuất huyết. Lách sưng. Con bệnh tiêu chảy, nước tiểu có máu

Chó thường chết trong vòng 7 ngày sau khi có biểu hiện chảy máu mũi. Nếu chảy máu nhiều thì có thể chết trong vòng 1 ngày.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

- Chẩn đoán

Bệnh thường khó khăn vì bệnh ở dạng tiềm tàng, triệu chứng thể hiện không rõ rệt

+ Trong quá trình phát bệnh không có dấu hiệu đặc trưng, dễ nhầm lẫn bệnh khác.

+ Dễ bị nhầm lẫn ngộ độc: do chảy máu ở các vùng niêm mạc nhìn thấy

+ Trong phòng thí nghiệm: làm tiêu bản máu, nhuộm giemsa, kiểm tra dưới kính hiển vi tìm Ricketsia. (các phương pháp khác: ELISA, PCR)

- Điều trị

Dùng kháng sinh để điều trị: Doxycylin: 5 – 10mg/1kgP uống, tiêm tĩnh mạch, ngày 2 lần, 10-15 ngày.

Oxytetracyclin: có tác dụng tốt, liều 22mg/1kgP, uống hoặc tiêm bắp, ngày 3 lần cách đều nhau. Kéo dài tối thiểu 2 tuần.

Amoxcicyclin cũng có tác dụng tốt.

Nếu bệnh ở thể mạn tính: dùng kéo dài 1-2 tháng.

+ Khi con vật chảy máu nhiều thì tiếp máu.

+ Thể nhẹ hơn thì truyền dịch. Khi con vật yếu tốc độ truyền 60-80 giọt/phút, không được quá nhanh sẽ gây sốc. Mùa đông chú ý đến nhiệt độ truyền.

+ Sốt cao: dùng các thuốc giảm sốt (analgin, paracertamol...).

+ Tăng sức đề kháng: vitamin C để tăng tính bền vững của mạch quản; vitamin B_{12} để tăng cường sản sinh các tế bào máu, bền vững thành mạch.

+ Con vật bị tiêu chảy, nôn (không điển hình). Nếu nôn nhiều dùng thuốc chống nôn.

+ Đi tiểu ra máu, nguy cơ nhiễm trùng đường niệu dùng Urotropin.

- Phòng bệnh

Diệt ngoại ký sinh trùng, động vật tiết túc kí sinh: ve, bọ, chấy, rận...

+ Trên cơ thể động vật:

- Thuốc dạng xịt: fronline, hantox-spray.
- Tắm nước sắc: lá cây cúc quỳ, hạt củ đậu...
- Vòng đeo cổ tránh ve, bọ chét...

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

+ Ngoài môi trường:

- Dùng bẫy bọ chét.
- Phun hantox, các loại thuốc trừ sâu dùng trong nông nghiệp.

BỆNH GIUN ĐŨA

● Ascariasis

I . NGUYÊN NHÂN

Bệnh giun đũa do Toxocara canis họ Anisakidae thường gây bệnh mạnh ở chó con; Toxocara leonina họ Ascaridae ký sinh ở chó trên 6 tháng; Toxocara mystax ký sinh ở mèo. Là bệnh phổ biến của chó, mèo trên khắp các châu lục. Bệnh thường gây ra ở chó con, mèo con từ 1-4 tháng tuổi. Chó mèo nhiễm bệnh do ăn phải trứng giun có lẫn trong thức ăn, nước uống hay các đồ dùng có lẫn mầm bệnh, trứng phát dục đến giai đoạn ấu trùng cảm nhiễm, ấu trùng cảm nhiễm trong ruột chui ra khỏi trứng xuyên vào thành ruột, lột xác trở thành giun trưởng thành, lại tiếp tục đẻ trứng và sinh sôi nẩy nở gây bệnh cho loài chó, mèo.

Ấu trùng của loài Toxocara canis còn có thể qua hệ tuần hoàn của chó mẹ khi mang thai và đi vào bào thai, do đó chó con sau khi sinh ra đã mang sẵn mầm bệnh trong cơ thể, đến 21 ngày tuổi gây thành bệnh nặng cho chó con.

II. SINH HỌC

Tham khảo giáo trình KST

III. TRIỆU CHỨNG

Giun ký sinh trong ruột non của chó mèo gây tác hại cơ giới, chiếm đoạt chất dinh dưỡng và tiết độc tố. Chó, mèo trưởng thành khi bị nhiễm giun đũa thường không biểu hiện rõ nét, chỉ gầy còm, lông xơ xác, đôi khi nôn khan, nhưng nó là vật chủ mang mầm bệnh. Bệnh giun đũa gây tác hại chủ yếu ở chó, mèo nhỏ từ 20 ngày tuổi đến 2-3 tháng tuổi

Biểu hiện:

- Thân gầy còm, lông xơ xác, kém ăn, suy nhược, thiếu máu.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

- Bụng phình to như bụng cóc, căng tròn, thỉnh thoảng có từng đoạn ruột nổi lên nhu động, ấn tay vào đó có cảm giác cứng chặt, đó là đoạn ruột bị giun lèn chặt.

- Chó, mèo nôn mửa, tiêu chảy, rên rỉ do đau bụng, có khi nôn ra giun hay phân thải ra ngoài màu xám trắng, thối khắm và ra cả giun.

- Chó, mèo nhỏ thì bị bệnh nặng, các ấu trùng do quá trình di hành trong cơ thể làm tổn thương gây viêm gan, thận, phổi, có khi tắc ống ruột, tắc mật, đôi khi giun đũa trọc thủng ruột. Độc tố giun đũa có thể tác động đến thần kinh trung ương gây co giật

III. PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH

3.1. Phòng bệnh

- Vệ sinh trong ăn uống: Ăn chín, ăn sạch và uống sạch.

- Định kỳ vệ sinh chuồng, cũi nhốt chó mèo và môi trường xung quanh để diệt mầm bệnh (phun Dipterex 1% diệt trứng giun, Chloramin B 0,5% trong 10 phút hay nước vôi 10%).

- Định kỳ kiểm tra phân chó mèo phát hiện mầm bệnh để dự phòng.

- Hàng ngày dọn chuồng thu nhặt phân đổ vào hố xử lý.

- Không thả rông chó mèo, không cho chó mèo tiếp xúc với bên ngoài và các chó, mèo khoẻ để hạn chế việc lây nhiễm mầm bệnh.

- Tẩy giun cho chó mèo định kỳ, tẩy cho chó mẹ để phòng lây nhiễm cho đàn con bằng một trong các loại hoá dược sau đây: Piperazin, Santonin, Vermox, Decaris, Levamisol, Niclosamide

3.2. Điều trị

Dùng một trong các loại hoá dược sau:

- Piperazin adipinat: Trộn thuốc vào sữa, cháo cho ăn hay hoà nước cho uống, liều 0,1-0,3g/ kg thể trọng. Hiệu lực tẩy đạt 90-100%, thuốc an toàn không gây phản ứng phụ.

Với chó mèo nhỏ hoà thuốc với nước cháo cho vào bình bú, hay cho vào bơm tiêm nhựa bơm vào miệng cho từng con.

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

Nếu bệnh nặng có thể cho uống 2 lần và kết hợp với thuốc bổ trợ như truyền sinh lý mặn ngọt, uống vitamin C, vitamin B1, vitamin B.complex.

- Vermox (Mebendazol, Mebenvet): Thuốc ở dạng viên nén 100mg/ viên. Chó mèo uống liều 80-100 mg/ kg thể trọng, chia làm 2 lần, uống trong 2 ngày để tẩy giun đũa.

- Levamisol: Dùng tẩy một lần, hiệu lực cao và an toàn, cho chó mèo uống với liều 15-20 mg/ kg thể trọng.

- Lopatol: Thuốc do hãng CIBA (Thụy sĩ) sản xuất. Thuốc có hiệu lực cao trong việc tẩy giun tròn và sán dây cho chó mèo từ 3 tuần tuổi và cả chó, mèo cái đang mang thai.

Hiệu lực tẩy sạch giun đạt 90-95%.

- Tetramison: Hiệu lực tẩy đạt 100%, an toàn không gây phản ứng phụ. Chó, mèo có thể cho uống với liều 10 mg/kg thể trọng, nếu dùng để tiêm với liều 7,5 mg/kg thể trọng.

Cho chó, mèo uống một lần sau khi ăn, không dùng cho chó, mèo đang mang thai ở giai đoạn cuối vì thuốc kích thích thần kinh phó giao cảm và cơ trơn

BỆNH GIUN MÓC

● Ancylostomatosis

I. NGUYÊN NHÂN

Do giun móc Ancylostoma canium gây nên. Đây là một trong những bệnh giun tròn gây thiệt hại nhiều nhất cho chó mèo. Bệnh phổ biến rộng khắp nơi trên thế giới và quanh năm. Chó mèo non thường mắc bệnh nặng hơn chó, mèo trưởng thành.

Chó, mèo nhiễm bệnh biểu hiện đặc trưng là thiếu máu,viêm ruột cấp và mạn tính, có kèm theo chảy máu ruột, đặc biệt chó mèo non từ 2-4 tháng tuổi khi mắc bệnh tỷ lệ chết cao từ 60-80%. Trứng giun móc theo phân thải ra ngoài, nở ra ấu trùng rồi thành ấu trùng cảm nhiễm bám vào thức ăn, nước uống và môi trường

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

xung quanh. Chó, mèo nuốt phải ấu trùng cảm nhiễm qua thức ăn nước uống vào đường tiêu hoá, những giun trưởng thành sống ở ruột non, tập trung ở phần tá tràng. Ấu trùng cảm nhiễm thải ra môi trường xung quanh, có thể qua da mà gây bệnh cho con vật. Khi qua da chó mèo con, ấu trùng không gây ra phản ứng cục bộ, nhưng khi qua da chó mèo trưởng thành, ấu trung gặp sự phản ứng mạnh mẽ của da, thể hiện viêm tấy rõ rệt do ấu trùng chết tạo ra

II. TRIỆU CHỨNG

Trong quá trình ký sinh trong đường tiêu hoá, giun móc gây ra các biến đổi bệnh lý do hai yếu tố: Tác động cơ học và ảnh hưởng của độc tố.

- Vật bệnh nôn mửa liên tục, có khi nôn ra máu, bỏ ăn hay ăn rất ít do hậu quả chảy máu niêm mạc ruột, giun móc khi bám vào ruột hút máu tiết ra một chất kháng đông và đưa đến hiện tượng xuất huyết ruột, gây tổn thương, trên cở sở đó các vi khuẩn gây bệnh có điều kiện phát sinh và gây các bệnh truyền nhiễm khác.

- Rối loạn tiêu hoá, viêm ruột cấp tính và mạn tính, do tác động cơ giới và độc tố của giun móc nên xuất hiện bệnh tiêu chảy dữ dội, phân lẫn máu màu cà phê hoặc màu đen có dịch nhày và mùi tanh khắm.

Gia súc non thường chết do mất máu, mất nước.

- Xuất hiện hội chứng thần kinh do độc tố giun móc thấm vào máu đi khắp cơ thể.

- Khi gia súc khoẻ và mắc giun móc lần đầu bệnh có thể nhẹ hơn và thời gian dài hơn, biểu hiện chủ yếu là triệu chứng thiếu máu, chảy máu ruột, tuy nhiên chỉ sau 2-3 tháng sẽ tự khỏi bệnh nếu như chăm sóc và nuôi dưỡng tốt.

III. PHÒNG TRỊ

3.1. Phòng bệnh

- Vệ sinh trong ăn uống: ăn chín ăn sạch và uống sạch để ngăn ngừa ấu trùng giun móc.

- Định kì tẩy uế vệ sinh chuồng, cũi nhốt chó mèo và môi trường xung quanh để diệt mầm bệnh (phun Dipterex 1% diệt chứng giun, Chloram B 0,5% trong 10 phút hay nước vôi 10%)

- Hàng ngày dọn chuồng thu nhặt phân đổ vào hố xử lý.

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

- Định kì kiểm tra phân phát hiện mầm bệnh để điều trị dự phòng.

- Không thả rông chó mèo, không cho chó mèo bệnh tiếp xúc với môi trường ngoài để hạn chế lây nhiễm mầm bệnh.

- Định kì 4 tháng tẩy 1 lần để phòng lây nhiễm bằng một trong các hoá dược sau đây: Mebendazon, Dovenix

3.2. Điều trị

Nguyên tắc chung: Tẩy giun móc bằng thuốc đặc trị, điều trị triệu chứng và thuốc bổ trợ.

* Thuốc tẩy: có thể dùng một trong các loại thuốc sau:

+ Mebendazol (Vermox): loại thuốc thường dùng cho thú y do Hungari sản xuất, mebendazol không những tẩy được hầu hết các loại giun tròn kí sinh đường tiêu hoá mà còn có tác dụng tẩy một số loài sán dây với vật nuôi.

Chó mèo bệnh uống với liều 80-1000mg/kg thể trọng. Thuốc chia làm 2 lần uống trong 2 ngày để tẩy giun đũa và chia làm 3 lần uống trong 3 ngày để tẩy giun móc, giun tóc và sán dây.

+ Dovenix: thuốc do hãng Rhone-Merieux của Pháp sản xuất. dovenix là dung dịch có chứa 25% hoạt chất của Nitroxynil, tác dụng tốt với giun móc chó, an toàn không phản ứng phụ.

Tiêm dưới da cho chó với liều 1ml/20-30kg thể trọng, trước khi tiêm nên pha loãng thành 2,5%.

Chú ý: dung dịch Dovenix có thể nhuộm mầu làm bẩn tay và các dụng cụ khác, có thể làm sạch bằng Natri hyposulfit 5%.

+ Levamisol 7mg/ 1kg TT., cho uống hay tiêm dưới da.

+ Exotral 1 viên/ 5kg TT., cho uống.

+ Han-lopatol 1viên/ 5kg TT., cho uống.

+ Canex 1viên/ 10kg TT., cho uống 1 liều không cần nhịn đói.

* Điều trị triệu chứng

- Điều trị viêm ruột: Biseptol cho uống liều 1g/ngày, mèo uống 0,5g/ngày, ngày uống 2 lần; hoặc Trimethazol 24% tiêm bắp thịt liều 0,5-1ml/con.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

- Chống chảy máu ruột: Vitamin K tiêm bắp liều 1ml/con với chó, 0,5ml/con với mèo, ngày tiêm 2 lần.

- Bổ sung các thuốc trợ lực tăng cường sức đề kháng của cơ thể như:

Glucoza 30%: Tiêm tĩnh mạch liều 5ml/con.

Vitamin B1 2,5%, vitamin C 5%, B. complex tiêm bắp liều 3-5ml/con.

- Truyền huyết thanh mặn ngọt dẳng trương 100-150ml/kg thể trọng/ngày.

BỆNH GIUN TIM Ở CHÓ

● Bệnh giun chỉ nhỏ

1. Căn bệnh

Do loại giun nhỏ Dirofilaria unmitis, thường ký sinh ở bên trong tim, tâm thất, mạch máu lớn (động mạch,tĩnh mạch). Có hình thái dài và nhỏ.

Kích thước con đực dài 12 – 18 cm, con cái dài 25 – 30 cm.

2. Vòng đời

- KCTG : một số loài muỗi (Anopheles, Culex, Acdes, Mansonia)

- Giun trưởng thành kí sinh ở tim và mạch máu lớn gàn tim, nó đẻ ra các ấu trùng chuyển động (Micrifilaria). Ấu trùng chuyển động đi vào vòng tuần hoàn của cở thể (đi theo máu). Khi muỗi hút máu,sẽ hút luôn cả ấu trùng vào cở thể muỗi và sẽ chuyển thành dạng ấu trùng gây nhiễm (mất 2 – 3 tuần). Khi muỗi đốt vào cơ thể động vật, ấu trùng gây nhiễm cư trú ở da và mô liên kết dới da (khoảng 3 – 4 tháng) sau đó nó vào máu,vào vòng tuần hoàn, đi vào tim và phát triển thành dạng trưởng thành.

Thời gian hoàn thành vòng đời 8 – 9 tháng, giun trưởng thành sống rất lâu trong cở thể chó (8 – 9 năm).

3. Dịch tễ

Bệnh có khắp nơi trên Thế giới, nhưng thường gặp ở những vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới, khí hậu nóng ẩm có nhiều muỗi hoạt động.

Bệnh có thể lây sang người, khi muỗi mang ấu trùng gây nhiễm đốt sang người, người sẽ mắc bệnh.

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

4. Triệu chứng

Thông thường, triệu chứng của bệnh giun tim không nhận biết được cho đến khi giun phát triển thành dạng trưởng thành. Chó có thể nhiễm bệnh 9 – 10 tháng vẫn chưa có triệu chứng. Khi giun trưởng thành đủ nhiều sẽ gây viêm thành mạch quản; nếu quá nhiều dẫn đến nghẽn mạch. Lượng máu về tim không đủ, gây hở van tim. Phần bên phải của tim giãn rộng, xảy ra đồng thời với hiện tượng phù phổi, gan, thận

- Con vật ho kéo dài, dạng mãn tính.
- Thở khó,cháy dớt dãi ở miệng
- Nếu nhiễm nhiều chó suy sụp nhanh, rất nhanh mệt khi vận động nhiều, chậm chạp, uể oải, lười vận động, gầy còm và thiếu máu kéo dài.
- Phù nề dưới bụng, ngực, vùng bàn ngón.
- Nước tiểu đục, lẫn máu do độc tố của giun gây viêm thận.
- Độc tố của giun có thể gây nhiễm độc thần kinh, gây liệt nhẹ 2 chân sau, động kinh.

5. Chẩn đoán

- Lấy máu xem tươi, kiểm tra dưới kính hiển ví
- Chẩn đoán nhanh bằng dụng cụ HW WITNESS^{TM} của hang Merial.
- Chụp X quang.
- Chẩn đoán bằng phản ứng ELISA.

6. Điều trị

* Trị ấu trùng

- Heartgart^{TM} plus (ivermectin, pyrantel), dạng viên nhai: 6mg/ 1kg TT.

Màu xanh dương: 1 viên/ chó dưới 11,5 kg.

Màu xanh lá cây: 1 viên/ chó từ 11,5 – 22,5 kg.

Màu nâu: 1 viên / chó từ 22,5 – 44kg.

Mỗi lần 1 viên, mỗi tháng 1 lần. thuốc chỉ có tác dụng với ấu trùng, không có tác dụng với giun trưởng thành. Một số giun non có thể bị tiêu diệt nhưng không có tác dụng diệt sạch.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

Thuốc có tác dụng phụ: động vật thẫn thờ, ói mửa, biếng ăn, tiêu chảy, hoa mắt, choáng váng, chảy nước dãi, co giật.

- Diethylcarbamazin: 3mg/ 1kg TT, chia 2 – 3 lần uống trong 1 ngày, uống sau bữa ăn, trong 4 – 5 ngày. Sau 1 tháng kiểm tra nếu còn ấu trùng giun cho uống tiếp liều nữa.

* Trị giun trưởng thành:

- Caparsolate : 0,2ml/ 1kg TT., chia 2 lần dùng trong 1 ngày, tiêm vào tĩnh mạch; liệu trình 2 ngày. Thuốc độc với gan và thận, vì vậy chỉ định thận trọng đối với những chó mắ bệnh gan, thận.
- Immiticide: 0,1ml/ 1kg TT., tiêm bắp thịt.
- Arsenamide: 1 năm sử dụng 2 lần, như là phương pháp tích cực diệt giun trưởng thành.
- Phẫu thuật lấy giun trưởng thành.

* Phòng bệnh bằng thuốc

- Revalution: dạng thuốc mỡ, sản xuất theo ống tuyp nhỏ. Dùng bôi ngoài da vùng gáy giữa 2 xương bả vai chó mỗi tháng 1 lần.
- Advantix: thuốc mỡ của hãng Bayer, dùng bôi ngoài da.

BỆNH SÁN LÁ GAN NHỎ

● Clonochis sinensis

1. Căn bệnh

Sán lá Clonochis sinensis thuộc họ Opisthorchidae, bộ Fasciolida

Đây là 1 loài sán lá kí sinh ở ống dẫn mật, nhỏ hơn sán lá gan kí sinh ở trâu bò. Phân bố rộng ở các nước Nam Á, ở nước ta, từ năm 1976 đã thấy có bệnh này, thường gặp ở vùng đồng bằng Bắc bộ, nhất là những nơi cư dân có thói quen ăn gỏi cá.Tỉ lệ nhiễm ở mèo cao nhất : 68%, chó 40%, người dưới 30%. Động vật sống càng lâu năm thì tỉ lệ nhiễm sán càng cao.

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

2. Vòng đời phát triển: Tham khảo giáo trình Ký sinh trùng.

3. Triệu chứng

Khi mắc ít sán bệnh tiến triển chậm, triệu chứng, bệnh tích không rõ ràng.

Triệu chứng thể hiện rõ khi nhiễm nặng : sán kí sinh hàng trăm đến hàng nghìn trên 1 cơ thể vật chủ.

Biểu hiện: viêm ống dẫn mật, tăng mô liên kết ở ống dẫn mật, nặng thì tắc ống dẫn mật, gan sơ hóa. Gan sưng to, con vật đau bụng, tích nước ở xoang bụng.

4. Chẩn đoán

Dùng phương pháp gạn rửa sa lắng tìm trứng trong phân

5. Điều trị

Thuốc tẩy sán:

- Hexacloparaxylen (Hetol): 50mg/kg TT., chia 3 lần, sử dụng trong 1 ngày vào 3 thời điểm khác nhau, 5 – 12 ngày
- Praziquantel : 35mg/ 1kg TT.
- Niclofolan : 1 – 2 mg/ kg TT., trong 2 – 3 ngày.
- Lopatol : 50mg/kg TT., cho uống hoặc trộn thức ăn, cho uống hoặc ăn 1 lần khi đói, sau 1 – 2 h cho con vật ăn uống bình thường.
- Han – lopatol : 1 viên nén/5kg TT., cho uống.

6. Phòng bệnh

- Quản lý phân của người và động vật ăn thịt: ủ phân sinh học, hầm Biogas
- Điều trị bệnh triệt để cho người và động vật.
- Người không nên ăn cá sống.

BỆNH SÁN DÂY DO *Taenia hydatigena*

● Bệnh ấu sán chó C. tenuicollis

1. Đặc điểm hình thái, vòng đời

Taeinia hydatigenna: Ký sinh ở ruột non chó, cáo, thú ăn thịt. sán dài 70 – 500cm, đốt già 12 × 6mm, trứng hình bầu dục, kích thước 38 × 38 µm. có vòng móc đỉnh đầu gồm 26 – 11 móc. Kí chủ cuối trung gian là lợn, dê, cừu, bò, có khi

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

thấy cả ở chó, mèo, người. Ấu trùng Cysticercus tennuicollis kí sinh ở gan, màng treo ruột của vật chủ trung gian khi được ký chủ cuối cùng nuốt phải thì sẽ phát triển thành dạng trưởng thành (sán trưởng thành)

Trứng theo phân ra ngoài gặp điều kiện thuận lợi trứng nở thành ấu trùng corracidium hình cầu, có nhiều lông bao quanh nên rễ bơi lội trong nước tìm kí chủ trung gian là những loài giáp xác ở nước (Cysclop stremus, Diaptomus glacilis). Ấu trùng này chỉ sống trong nước được 2 – 3 ngày. Nếu được ký chủ trung gian nuốt phải, ấu trùng mất lông, nhờ có 6 móc ấu trùng bám vào thành ruột sau 3 tuần thành ấu trùng Procercoid. Khi vầt chủ bổ xung ăn (cá) ăn vật chủ trung gian, ấu trùng này phát triển thành dạng ấu trùng gây nhiễm Plerocercoid trong cơ của vật chủ bổ sung. nếu người và gia súc ăn phải vật chủ bổ sung này ấu trùng sẽ phát triển thành sán trưởng thành sau 2 tháng. Sán trưởng thành ký sinh ở ruột người từ 10 -29 năm.

2. Dịch tễ học

Sán dây trưởng thành ở động vật ăn thịt tuổi thọ dài có khi tới hàng chục năm. Đốt sán già chứa nhiều trứng lại thường xuyên thải theo phân ra ngoài nên mầm bệnh được khuyếch tán rất nhiều ra môi trường bên ngoài. Người rễ mắc bệnh do tiếp xúc với chó, mèo.

Những nơi nuôi chó, mèo, gia súc thường mắc bệnh ấu trùng sán dây. Trứng sán dây có sức đề kháng mạnh với ngoại cảnh. Trứng sống lâu ở nơi ẩm ướt. Ở những nơi làm công tác kiểm soát sát sinh kém chó mèo thường mắc bệnh.

3. Cơ chế sinh bệnh

Do móc và giác bám khoẻ của sán khi kí sinh làm tổn thương niêm mạc ruột, mở đường cho vi khuẩn xâm nhập sâu vào trong cơ thể vật chủ. Sán cướp chất dinh dưỡng của kí chủ làm con vất gầy yếu, suy dinh dương. Khi nhiều sán ký sinh thường gây tắc ruột thủng ruột. Sán tiết độc tố làm con vật rối loạn thần kinh, trúng độc, chậm lớn.

4. Triệu chứng lâm sàng

Bệnh ở chó mèo (ký chủ cuối cùng)

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

Nói chung bệnh sán dây ở chó mèo ít gây ra những triệu chứng bệnh trầm trọng. Mức độ tùy thuộc vào giống chó, lứa tuổi và cường độ nhiễm. Móc bám của sán thường gây những tổn thương chảy máu và viêm ruột, nhiễm trùng thứ phát. Chó bệnh biểu hiện kém ăn, nôn (thỉnh thoảng), tiêu chảy, táo bón xen kẽ. Động vật gầy còm, ốm yếu, có thể tìm thấy đốt sán trong phân. Những cá thể mắc bệnh nặng có hội chứng thần kinh: run rẩy, ngơ ngác, dễ bị kích động; chó con bị mất nước nhiều có thể chết.

5. Chẩn đoán

Dựa vào triệu chứng lâm sàng kết hợp với kiểm tra phân tìm đốt sán hoặc trứng sán bằng các phương pháp gạn rửa sa lắng (tìm đốt sán) và phương pháp Fullerborn hoặc phương pháp Darling để tìm trứng.

6. Điều trị

Có thể dùng các thuốc sau để tẩy sán:

- Arecolin: 0,002 – 0,003 g/kg thể trọng, trộn lẫn với thức ăn. Cần nhịn đói trước khi cho thuốc.
- Divermin: 250 mg/kg thể trọng cho uống hoặc tiêm bắp.
- Dichlorophen: 200 mg/kg thể trọng cho uống.
- Niclosamide 80 – 100 mg/kg thể trọng, cho uống 1,2 liều vào buổi sáng khi con vật chưa ăn, 1h sau cho uống liều còn lại. sau khi uống liều 2 được 3h thì cho con vật ăn bình thường. khoảng 6 – 10h sau phát hiện sán chết và theo phân ra ngoài.

Sau 20 ngày tẩy lần 1 vẫn phát hiện đốt sán thì tẩy lần 2.

- Lopatol 50mg/kgTT., cho uống trực tiếp hay trộn với một ít thức ăn, chỉ uống 1 lần khi đói; sau đó cho ăn uống bình thường không phải ăn kiêng hay nhịn.
- Han – loptol 1 viên/ 5kg TT. Cho uống.
- Mebenvet 80 – 100 mg/kg TT cho uống 1 liều chia 3 lần, trong 3 ngày.
- Praziquantel: 35mg/kgTT cho uống.
- Fenbendasole 3mg/kgTT., cho uống.
- Exotral , thuốc viên : 1 viên/ 5kgTT., uống trước khi ăn. Chó con 2 tháng đầu : 1 tháng uống 1 lần. khi trưởng thành 1 năm uống 1 lần.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

- Bệnh nặng phải điều trị triệu chứng : ỉa chảy, mất nước, kế phát nhiễm trùng đường ruột.

7. Phòng bệnh

Phải định kỳ tẩy sán cho chó, mèo....

Không cho chó, mèo ăn thịt, phủ tạng sống hoặc phủ tạng có ấu sán.

Không cho chó, mèo vào khu vực chăn nuôi gia súc.

Không để Người , chó, mèo ăn cá sống. Quản lý tốt phân người, không làm hố xí trên ao cá.

BỆNH SÁN DÂY DO *Echinococcus gralulosis*

● Bệnh kén nước

1. Hình thái

Sán trưởng thành Echinococcus granulosus ở ruột non chó, mèo, thú ăn thịt, rất nhỏ, chỉ dài 2 – 6 mm, cơ thể có 4 đốt. Đốt đầu hình lê, đường kính 0.3 mm, có 4 giác bám tròn rất rõ, một mõm nhỏ nhô ra phía trước, trên mõm có 30 – 36 móc xếp thành hai hàng. Đốt cổ hẹp hơn đốt đầu trong đốt này có đủ bộ phận sinh dục đực cái. Đốt cuối cùng là đốt thừa.

Ấu trùng Echinococcuc granmulosis ký sinh ở gan, phổi, và các bộ phận khác của dê, cừu, lợn, người,... độ to nhỏ thay đổi theo tuỷ loài bằng hạt đậu hoặc bằng quả bưởi, có những nặng tới 60 kg. Có hai loại kén nước: loại một bọc và loại nhiều bọc.

2. Vòng đời

Sán trưởng thành sống kí sinh ở ruột non chó, mèo, cáo,.... trong ruột non thường có nhiều sán, vài trăm tới vài nghìn sán. Đốt sán chửa rụng theo phân ra ngoài, trứng sán khuyếch tán đi mọi nơi, lẫn vào thức ăn nước uống, đồng cỏ, nền chuồng, sân chơi. Khi kí chủ trung gian là dê, cừu, bò, lợn... nuốt phải trứng sán này vào đường tiêu hoá thai 6 móc nở ra, chui vào mạch máu, niêm mạc ruột, theo mạch máu về gan, phổi, và các tổ chức khác tiếp tục phát triển thành kén nước.

Thường thấy kén ở gan, các bộ phận khác ít thấy hơn.

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

Ấu trùng có thể sống vài năm, kí chủ cuối cùng ăn phải gan, phổi của súc vật có mang ấu trùng này, sau khi vào tới ruột, màng bọc tan đi, đầu sán thó ra bám vào niêm mạc ruột thành sán trưởng thành. Hoàn thành vòng đời cấn 2.5 – 3 tháng.

3. Dịch tễ học

Trứng có sức đề kháng mạnh với môi trường bên ngoài, đốt sán bò được trên đất, mùa đông lạnh, đốt sán chuyển động trên mặt bãi phân. Nhiết độ 50^0c chết sau 1h. Ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp làm chết trứng.

Bệnh có tính chất nguồn dịch thiên nhiên.Vì vậy đặc điểm dịch tễ học của bệnh có liên quan chặt chẽ tới sự phân bố và hình thái của hoang thú. Phạm vi kí chủ trung gian và kí chủ cuối cùng rất rộng nên thường phòng trừ rất phức tạp.

Người cũng có thể nhiễm Ấu sán. Ngoài ra Ấu sán còn kí sinh ở nhiều loài hoang thú. Sán trưởng thành kí sinh ở mèo, chó, thú ăn thịt...

4. Cơ chế sinh bệnh

Ảnh hưởng tới cơ thể kí chủ do độc tố và do ảnh hưởng cơ giới. Ấu trùng thường kí sinh ở gan, phổi, chèn ép các khí quan này, làm tổ chức bị teo dần và rối loạn chức năng sinh lý bình thường. Ngoài ra ấu trùng còn sản sinh độc tố làm cho con vật trúng độc, hô hấp khó, thân nhiệt tăng, ỉa chảy, có khi chết. Khi gan có nhiều ấu trùng làm cản trở quá trình sinh dịch mật dẫn đến gây rối loạn tiêu hoá. Gan sưng to ảnh hưởng tới hoạt động của hoành cách. để ép thực quản và tĩnh mạch cửa.

Mổ khám thấy mặt gan và phổi có nhiều chỗ lồi lõm, có khi thấy ấu trùng cắt đôi thấy nước và đầu sán chảy ra. Có khi bị vôi hoá, mủ, ầu trùng còn thấy ở thận.

5. Triệu chứng

6. Chẩn đoán

7. Điều trị

8. Phòng trừ

Các mục 5 – 8 như bệnh Ấu sán chó.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

BỆNH CẦU TRÙNG

● Canine Coccidiosis

Cầu trùng thuộc động vật đơn bào nguyên sinh (1dạng của protozoa) gây ra, thường thấy là Isospora canis sống trong đường ruột của chó, gây ra bệnh tiêu chảy phần lớn ở chó con dưới 6 tháng tuổi. Chó trưởng thành ít mắc vì chúng có khả năng miễn dịch mặc dù chúng có thể mang cầu trùng ở trong đường ruột và là kho thải các noãn nang ra ngoài qua phân gây lây lan bệnh .

1. Căn bệnh

- Cầu trùng thuộc động vật đơn bào nguyên sinh (1dạng của protozoa) gây ra.

- Đặc điểm sinh học: cầu trùng rất phát triển gồm sinh sản vô tính và hữu tính trong cơ thể.

2. Dịch tễ học

- Phát triển khá nhanh gây hậu quả nặng nề cho động vật.

- Bệnh có thể lây lan thành dịch.

- Động vật non (dưới 2 tháng) dễ bị nhiễm bệnh và phát triển bệnh nhanh hơn, nặng nề hơ so với động vật trưởng thành.

- Động vật đã trưởng thành và càng già thì các biểu hiện triệu chứng càng ít. Song chúng lại mang trùng và thường xuyên thải mầm bệnh ra môi trường theo phân là nguồn bệnh nguy hiểm nhất đối với động vật non.

- Môi trường ô nhiễm mầm bệnh, các thú hoang mang trùng là nguồn bệnh thứ hai.

- Các yếu tố nuôi dưỡng chăm sóc kém, vệ sinh môi trường không đảm bảo, động vật mắc các bệnh truyền nhiễm khác, bệnh mãn tính ở đường hô hấp thúc đẩy bệnh cầu trùng nặng nề hơn.

- Bệnh xảy ra quanh năm, nhưng dễ bùng phát hơn vào những tháng có mưa, nóng ẩm.

3**. Đường truyền lây**

Chó con sinh ra không mang cầu trùng trong đường ruột, sau đó thường xuyên tiếp xúc với phân của mẹ có chứa noãn nang của cầu trùng, cầu trùng xâm

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

nhập và phát triển trong đường ruột và gây bệnh. Ngoài chó mẹ, cầu trùng còn lây lan từ chó này sang chó khác qua tiếp xúc, phương tiện vận chuyển, bệnh viên điều trị.

4. Triệu chứng

- Thời gian nung bệnh 5-7 ngày.
- Con vật mệt mỏi ủ rũ, ăn ít, uống nhiều nước, sau đó tiêu chảy.
- Tiêu chảy có thể từ mức độ nhẹ tới rất nghiêm trọng tuỳ theo mức độ bệnh. Phân có thể lẫn máu và dịch nhầy bao phủ bên ngoài, đặc biệt là trong những trường hợp bệnh nặng.
- Thân nhiệt tăng nhẹ, con vật nôn ra các chất chứa, đái dắt, cào cấu lung tung.
- Thời kỳ cuối, chó có thể bị thiếu máu, nằm bẹp, kiệt sức rồi chết.
- Bệnh không kế phát các vi khuẩn khác triệu chứng sẽ giảm dần, khỏi sau 2 tuần.
- Đặc biệt, nhiều trường hợp bệnh rất nặng nhưng con vật vẫn chịu đựng được và tự khỏi. Vì vậy, bệnh Cầu trùng ở chó còn được gọi là bệnh tự giới hạn; khi không kế phát virus, vi khuẩn → triệu chứng của bệnh giảm sau 2 tuần.
- Sau khi có triệu chứng lâm sàng, ngày thứ 11mới quan sát được noãn nang thải ra ngoài, gây khó khăn cho chẩn đoán. Các noãn nang có thể được thải qua phân ở những chó đã hết triệu chứng trong nhiều tuần, đôi khi trong nhiều tháng.

5. Bệnh tích

- Xác gầy, lông xơ xác, niêm mạc nhợt nhạt.
- Bệnh tích tập trung ở ruột non, đặc biệt là đoạn dưới tá tràng và phần đầu của ruột già (manh tràng).
- Các đoạn ruột trên bị viêm cata, xuất huyết.

6. Chẩn đoán

- Dựa vào dấu hiệu về dịch tễ học, triệu chứng lâm sàng và mổ khám xác chết.
- Xét nghiệm phân bằng phương pháp Fulleborn hay Darling tìm noãn nang.

7. Điều trị

+ Trị cầu trùng

- Sulfaguanidine 180mg/ 1kg TT., cho uống 5 ngày liền.
- Sulfapiridazine 180mg/ 1kgTT., cho uống 5 ngày liền.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

- Kết hợp sulfuaguanidine 120mg/ 1kg TT và Sulfapiridazine 120 mg/ 1kg TT., cho uống 5 ngày liền.
- (?)Có thể dùng thuốc: sulfadimethoxine (Albonđ) và trimethoprim-sulfadiazine (Tribrissenđ) đều có hiệu qủa trong điều trị và phòng bệnh do cầu trùng. Liều 180mg/ kg TT., cho uống 5 ngày liền.
- Nitrofurazone 20mg/ 1kg TT., uống 5 ngày.

Tuy những thuốc này không giết chết cầu trùng nhưng có tác dụng kìm hãm sự sinh sản của chúng, việc loại bỏ cầu trùng ra khỏi ruột là không thể nhanh chóng, gồm việc ngăn chặn sự sinh sản của động vật nguyên sinh, thời gian để kháng thể hình thành trong cơ thể chúng và di tới các cơ quan. Liệu trình điều trị thường kéo dài từ 1 đến 3 tuần.

+ Chống mất nước

+ Cầm máu

+ Tăng sức đề kháng

7. Phòng ngừa và kiểm soát

Cầu trùng được phân tán đi nhờ phân của những động vật mang mầm bệnh, vì vậy việc kiểm soát chặt chẽ phân của con vật là điều rất quan trọng. Tất cả phân sẽ được loại bỏ. Chuồng nuôi cần phải được bảo đảm rằng thức ăn, nước uống không bị vấy nhiễm bởi phân. Nước sạch sẽđược cung cấp mọi lúc. Không phải đại đa số thuốc sát trùng đều chống được cầu trùng, đốt phân, hấp ướt, dội nước sôi, hoặc dung dịch NH3 loãng là những cách tốt nhất để tiêu diệt cầu trùng. Cầu trùng có thể chống lại sựđông lạnh(không bị tiêu diệt khi nhiệt độ thấp).

Gián và ruồi là những con vật có thể mang cầu trùng từ nơi này đến nơi khác.Trong trường hợp chuột và các động vật khác có thểăn phải cầu trùng và sauđó bị chó giết và ăn thịt, nó có thể gây bệnh cho chó. Bởi vậy việc kiểm soát chặt chẽ côn trùng và loài gặm nhấm là rất quan trọng trong việc phòng chống bệnh cầu trùng

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

BỆNH L Ỵ DO AMIP

I. KHÁI NIỆM

Chứng viêm đại tràng cấp tính hay mãn tính do amip gây ra, phổ biến ở người và các loài linh trưởng. Ở chó không phổ biến lắm.

II. NGUYÊN NHÂN

Do Emtamoeba Hystolytica gây ra. Emtamoeba Hystolytica tồn tại dưới hai hình thức, hoạt động và không hoạt động, thể hoạt động cũng có 2 thể khác nhau: thể ăn hồng cầu gây bệnh và thể chưa ăn hồng cầu chưa gây bệnh. ở chó mèo khoẻ mạnh Emtamoeba Hystolytica cư trú chính ở đại tràng nhưng nó ở thể hoạt động chưa ăn hồng cầu

Khi sức đề kháng của cơ thể bị giảm sút do các nguyên nhân như thay đổi thời tiết, thức ăn hay nhiễm khuẩn, tổn thương đường ruột nhất là đại tràng thì nó nhanh chóng trở thành thể hoạt động ăn hồng cầu gây bệnh cho chó mèo. Sau khi nhiễm bệnh con vật có thời gian ủ bệnh từ 15-20 ngày. Trong thời gian này bào nang phát triển thành thể hoạt động và chờ thời cơ gây bệnh

III. TRIỆU CHỨNG

Ở thời kỳ đầu chó mèo ăn ít, nhiệt độ không tăng, phân táo sau đó phân chuyển sang mầu vàng xám và có mùi tanh khắm, con vật đi ỉa nhiều lần trong ngày. Mỗi lần đi ỉa thì rặn nhiều lần luôn cong lưng để dặn và biểu hiện đau đớn, rên rỉ. Sau đó vài ngày chó đi ỉa mỗi lần rất ít phân, phân chỉ là một thứ dịch nhầy như mũi, tiếp theo phân chuyển sang mầu đỏ tươi hay lờ lờ máu cá có khi có mủ do bội nhiễm, nếu không điều trị kịp thời chó mèo sẽ bị chết trong vòng 5-7 ngày do bị kiệt sức.

Những trường hợp chó, mèo được chăm sóc tốt có thể chuyển sang thể lỵ mãn tính; khi đó E. hystolytica sẽ cư trú ở trong vách ruột đợi cơ hội gây bệnh. Ở chó bị thể lỵ mãn tính thỉnh thoảng lại phát bệnh 1 đợt mỗi đợt khoảng 5-7 ngày làm cho chó bị gầy còm.

IV. CHẨN ĐOÁN

Dựa vào triệu chứng lâm sàng chó mèo đi tiêu chảy, mỗi lần đi ỉa phải rặn khó khăn, đi nhiều lần trong 1 ngày lượng phân 1 lần đi rất ít và luôn có lẫn chất

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

lầy nhầy và máu. Để có kết luận chính xác ta có thể lấy phân làm xét nghiệm trong phòng thí nghiệm về ký sinh trùng

V. PHÒNG VÀ TRỊ

5.1. Phòng bệnh

+Thực hiện tốt công tác vệ sinh thú y ăn sạch, uống sạch, ở sạch

+ Định kỳ lấy phân làm xét nghiệm để phát hiện mầm bệnh

+ Phân chó phải được thu gom và ủ theo phương pháp ủ sinh vật học

5.2. Trị bệnh

a. Nguyên tắc điều trị

+ Dùng hoá dược đặc trị diệt Amip, thuốc phải dùng đúng liều tránh tình trạng Amip chuyển thành bào nang và chờ dịp tái phát khi có cơ hội đồng thời cần thiết phải phối hợp các loại thuốc kháng sinh chống hiện tượng bội nhiễm.

+ Bổ sung các loại thuốc trợ sức trợ lực các loại vi ta min nhằm làm tăng cường sức đề kháng cho cơ thể chó mèo.

+ Tăng cường khâu hộ lý, chăm sóc nuôi dưỡng và vệ sinh thú y.

b. Dùng thuốc và hoá dược

+ Metronidazol với liều 40-50mg/ kgTT., cho chó mèo uống trong 1 ngày, dùng liên tục trong 5 ngày liền sau đó nghỉ 5 ngày rồi lại tiếp tục dùng lần thứ 2.

+ Becberin liều 50mg/kgTT trong 1 ngày cho chó, mèo uống liên tục 5 ngày liền.

+ Dyhydro Emitin 3mg/ kgTT., cho chó mèo uống 4-5 ngày liền.

+ Chống vi khuẩn bội nhiễm bằng kháng sinh: có thể dùng các loại sulfamide như: Bisepton 1g/ 10kgTT., ngày uống 2 lần. Trimethoxazol 24% tiêm bắp với liều 1ml/ 5kgTT., tiêm 5-7 ngày liền. Dùng kháng sinh: Gentamycin, Kanamycin…

+ Chú ý cần thiết phải dùng các loại thuốc cầm máu như vitamin K.

+ Tăng cường sức đề kháng và bồi bổ cơ thể cho chó, mèo như truyền dung dịch huyết thanh mặn ngọt đẳng, tiêm bắp các loại vitamin B_{12}, B_1, C cho động vật mắc bệnh.

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

c. Thuốc nam

Bài 1: Lá mơ tam thể 50g, trứng gà 1 quả. Cách dùng như sau: thái nhỏ lá mơ sau khi đã rửa sạch để ráo nước cho vào chảo đảo đều cho lá mơ chín tới đập trứng gà vào rồi đảo cho chín đều cho chó mèo ăn ngày 2-3 lần cho ăn liên tục từ 3-5 ngày.

Bài 2: chữa lỵ Amip tiêu chảy: Búp sim hoặc lá sim non 100gr cho vào 1lít nước thường rồi đem sắc dặc còn lại 300-500ml cho thêm 10gr muối ăn rồi cho chó mèo uống hàng ngày.

Bài 3: Dùng cam thảo 10gr, lá chè 100gr, nước thường 300ml đem đun sôi còn lại khoảng 100ml cho chó mèo uống mỗi lần 10-15ml. Ngoài ra kinh nghiệm nhiều nơi cho thấy có thể dùng tỏi giã nhỏ ngâm với nước sôi để nguội với tỷ lệ 10% lọc lấy nước thụt vào trực tràng chó mèo cho kết quả điều trị cao.

BỆNH LỴ DO GIARDIA INTESTINALIS

● Giardiasis

● Lambliasis

I. NGUYÊN NHÂN

Bệnh do Giardia intestinalis gây ra. Giardia intestinalis sống trong lòng ruọt non, đa số ở tá tràng, một số nhỏ ở manh tràng và có khi xâm nhập và ống mật. Khi gặp các điều kiện không thuận lợi, Giardia intestinalis sẽ trở thành bào nang (thể lây nhiễm). Chó mèo bị bệnh hàng ngày thải phân ra ngoài kèm theo nhiều bào nang, bào nang sẽ phát triển thành thể Giardia intestinalis hoạt động. Chó khỏe ăn phải bào nang thì lây bệnh.

Bệnh thường thấy ở chó, nhất là cho non dưới 4 tháng tuổi, ít gặp ở chó trưởng thành. Bệnh xảy ra quanh năm, tuy nhiên gặp nhiều vào những tháng nóng, mưa nhiều.

Bệnh còn xảy ra ở chim và hầu hết các loài gia súc, ngay cả người cũng mắc. Bệnh phổ biến ở chó mèo. Bệnh có thể lây từ chó mèo sang người và ngược lại.

Bệnh phân bố rộng rãi trên toàn cầu.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

II. TRIỆU CHỨNG

Giardia intestinalis cư trú ở thành ruột, ống dẫn mật, khi chúng di chuyển gây nên những tổn thương và trên cơ sở đó vi khuẩn gây bệnh đường ruột sinh sôi và phát triển gây viên ruột.

- Đầu tiên con vật ăn ít hoặc bỏ ăn, nôn mửa liên tục, sau khi nôn hết ra thức ăn và nước uống thì nôn ra nước dãi đặc quánh và dịch mật màu vàng, đôi khi còn nôn ra cả máu do những cơn co thắt của da dày.
- Tiếp theo vật bị tiêu chảy, trong nước phân có nhiều niêm mạc lầy nhầy và mùi tanh khẳm, bệnh nặng phân có lẫn máu màu nâu như bã cà phê do viêm xuất huyết ở dạ dày và ruột non.
- Một số ít trường hợp chó bị viêm túi mật do Giardia intestinalis di chuyển lên gan và mật.

Nói chung, các biểu hiện của bệnh không có những nét đặc trưng. Bệnh không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời con vật sẽ chết vì không ăn, nôn nhiều gây mất nước, rối loạn điện giải. tuy nhiên, một số con có sức đề kháng tốt sẽ qua khỏi những cơn nguy kịch và chuyển thành mãn tính

III. CHẨN ĐOÁN

Không thể dựa vào triệu chứng lâm sàng. Nếu căn cứ vào triệu chứng lâm sàng rất khó phân biệt với các bệnh khác.

Chủ yếu chẩn đoán bằng phương pháp ký sinh trùng học, xét nghiệm phân tìm Giardia intestinalis thể hoạt động và bào nang.

IV. PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH

1. Phòng bệnh

- Tăng cường ăn sạch, đầy đủ chất dinh dỡng uống sạch, ở sạch.
- Tất cả thức ăn cho chó phải nấu chín, không ăn thức ăn ôi thiu, nấm mốc.
- Định kỳ kiểm tra phân chó phát hiện mầm bệnh để dự phòng.
- Phân chó phải xử lý bằng ủ phân sinh vật học.
- Định kỳ tiêu độc vệ sinh môi trường xung quanh bằng phun dung dịch Chloramin B 0,5% trong 10 phút, hay nước vôi 10%.

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

2. Điều trị

- Nguyên tắc điều trị: điều trị nguyên nhân kết hợp điều trị triệu chứng và các thuốc bổ trợ nâng cao sức đề kháng chống bệnh.

- Điều trị triệu chứng: có thể dùng một trong các hoá dược sau để diệt mầm bệnh:

+ Metronidazol: cho uống với liều 30-50mg/ 1kg thể trọng, chia làm 2 lần cho chó uống trong ngày; uống vào sáng và chiều, liên tục 5-6 ngày liền. nghỉ 5-6 ngày sau đó lại cho uống liệu trình tiếtp theo như trên.

+ Alben dazone 25mg/ 1kg TT., ngày uống 2 lần, uống 2 ngày.

+ Fenbendazone 50mg/ 1kgTT., ngày uống 1 lần, uống 3 ngày.

- Chống bội nhiễm đường ruột:

+ Bisepton (trimazol):cho uống liều 1g/ 10kg thể trọng, ngày uống 2 lần.

+ Trimethaxazol 24%: tiêm bắp, liều 1ml/con, tiêm liên tục 7 ngày liền. Trên thị trường thuốc thú y có một số loại chống viên ruột có hiệu quả:

+ Kanacolin: thành phần gồm Tiamulin HF, Kanamucin sulfat, Colistine sulfat, Neomycin sulfat, Vitamin B. complex. Hòa vào nước cho chó uống với liều 1g/ 5kg thể trọng, uống 2-3 lần trong ngày.

+ Gentacosflox: thành phần gồm Gentamycin sulfat và Enrofloxacin HCl. cho chó, mèo uống với liều 1g/ 5kg thể trọng; uống 2-3 lần trong ngày.

- Chữa triệu chứng:

+ Kết hợp thuốc chống nôn: Atropin sulfat 0,1%, tiên bắp 1ml/10 kg TT.

+ Vitamin K: chống xuất huyết, tiêm bắp 1ml/ con, ngày tiêm 2 lần.

+ Dùng thuốc có tác dụng se niêm mạc ruột như: Tanin hoà nước sạch cho uống 0,1-0,5g/ ngày, Carbonat bismuth liều 0,3-0,4g/ ngày.

+ Dung dịch điện giải: pha theo hướng dẫn cho uống liên tục trong ngày, chống mất nước

- Bổ sung các thuóc trợ lực tăng sức đề kháng cơ thể như:

+ Truyền huyết thanh mặn ngọt đẳng trơng: 100-150ml/ 10kgthể trọng/ ngày.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

+ Glucoza30%: tiêm mạch máu với liều 5ml/ con; cho chó và 2-3ml/ con cho mèo.

+ Vitamin B12,5%, vitamin C, B.complex tiêm bắp liều 3-5g/ ngày

+ Vitamin B12: chống thiếu máu, liều 100g/ ngày.

+ Promix: (Thành phần gồm cú Promethazin, Dipyrone, Dexamethasone): giảm sốt, an thần. Tiêm bắp liều 1ml/5kg thể trọng/ngày

- Thụt rửa ruột bằng thuốc tím pha loãng (0,1%), dung dịch Bicacbonat natri 2%
- Một số bài thuốc nam chữa lỵ (?)

+ **Bài 1:** Chữa lỵ

Lá chè 100g

Cam thảo 10g

Nước 100ml

Đun sôi 30 phút, lọc chắt lấy nước; sau đó lại cho tiếp nước vào ngập bã, đun, cô đặc; dồn cả 2 nước, cô đặc sao cho còn lại 100ml. Cho chó uống mỗi lần 5-10ml hoặc có thể thụt hậu môn, liều mỗi lần 100ml, thụt từ 1-2 lần trong ngày.

+**Bài 2**: Chữa lỵ trực trùng Shiga

Lá mơ tam thể 30-50g

Trứng gà 1 quả

Lá mơ rửa sạch, thái nhỏ trộn trứng gà, bọc lá chuối đem nướng. Ngày ăn 2-3lần; sử dụng cho chó, mèo và các gia súc quý hiếm rất hiệu quả (?).

+**Bài 3**: Chữa lỵ, tiêu chảy, vết loét, vết thương nhiễm trùng

Búp sim, lá sim non 100g

Nước 1000ml

Đun sôi, cô đặc còn 300-500ml, cho chó uống trong ngày, có thể cho thêm ít muối hoặc đường cho dễ uống.

+ **Bài 4**: chữa lỵ Amip, lỵ trực trùng

Tỏi giã nát, ngâm với nước sôi để nguội, với tỷ lệ 5-10%. Ngâm một lúc và lọc lấy nước để thụt hậu môn, mỗi ngày thụt khoảng 100ml.

Tỏi sống cho uống liền 3g/ con/ lần; ngày uống 3 lần.

Chú ý: nước tỏi 10% còn dùng chữa các vết thương có mủ, tẩy giun kim...

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

+**Bài 5**: Chữa lỵ, kém ăn

Chè hương 100g

Cam Thảo 10g

Nước 300ml

Lấy chè và cam thảo đổ nước cho vào ngập, đun sôi 30 phút, cô đặc và lọc lấy 100ml; mỗi lần cho uống 10-20ml/ con; ngày uống 3-4 lần.

+**Bài 6**: chữa lỵ, sốt, tiêu chảy

Ô dược 20g

Hương phụ 20g

Tán nhỏ cho chó uống 8-10g trong ngày. Có thể cho thêm 1000ml nước sạch, đun sôi sắc đặc còn 300ml cho chó uống trong 2-3 ngày.

+ **Bài 7**: Chữa lỵ, tiêu chảy, các vết thương nhiễm trùng

Sim (búp, lá non) 50g

Nước sạch 600ml

Đun sôi, cô đặc còn 200ml cho chó uống hàng ngày

Chè hương 100g

Cam thảo 10g

Nước sạch 100ml

Đun sôi 30 phút, lọc lấy nước sắc 1; sau đó cho tiếp nước vào đun sôi, lọc nước sắc 2. Gộp cả 2 nước sắc vào cô đặc, sao cho còn 100ml. Mỗi lần uống từ 20-25ml, ngày uống 2 lần.

Có thể thụt hậu môn bằng nước chè trên, ngày thụt 1-2 lần, mỗi lần 100ml.

BỆNH LÊ DẠNG TRÙNG

● Babesiosis

I. Nguyên nhân

Phổ biến nhất là do Babesia canis và Babesia gibsoni. Chúng ký sinh bên trong hồng cầu của chó.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

- Babesia canis là loại đơn bào có dạng hình quả lê, giọt nước hay hình hạt đậu. Chúng thường tồn tại thành đôi, nhưng có khi cũng nhìn thấy tới 8 đơn bào trong một hồng cầu. Babesia canis có kích thước (5 – 7) x (2 – 4) µm.

- Babesia gibsoni có kích thước nhỏ hơn Babesia canis, nó có đường kính từ 1 đến 3 µm và thường thấy bên trong hồng cầu ở dạng vòng nhẫn đơn lẻ.

Bệnh có ở hầu hết các tỉnh miền núi và đồng bằng.Ve Rhipicephalus sanguineus là môi giới truyền bệnh cho chó. Babesia canis kí sinh chủ yếu trong hồng cầu. Babesia sinh sản cả vô tính và hữu tính.

Sinh sản vô tính: từ 1 lê dạng trùng trong hồng cầu sẽ nẩy chồi thành 2 kí sinh trùng và thoát ra khỏi hồng cầu khi hồng cầu đó bị phá huỷ rồi sau đó lại nhiễm vào một hồng cầu khác. Qúa trình này sảy ra liên tục trong cơ thể chó.

Sinh sản hữu tính: Ve Rhipicephalus sanguineus là kí chủ trung gian của Babesiosis. Ve bám vào chó bệnh hút máu, lê dạng trùng chui vào ve, phát triển thành bào tử, khi ve hút máu chó khỏe sẽ truyền bào tử sang chó; bào tử đó xâm nhập vào hồng cầu và gây bệnh.

Chó nhập ngoại và chó non dưới 6 tháng tuổi dễ mắc và thường bệnh nặng, tỷ lệ chết cao 60-70%.

II. Triệu chứng

Bệnh xuất hiện ở 2 thể cấp tính và mạn tính

1. Thể cấp tính

Chó sốt cao 39,5 - 40,5^{0}c, sốt kéo dài trong 2-4 ngày, chó ủ rũ và nằm bệt. Các niêm mạc nhợt nhạt do thiếu máu, số lượng hồng cầu giảm rõ rệ, bạch cầu tăng 10-12nghìn mm^3. Nước tiểu lúc đầu trắng đục sau đỏ nâu. Chó khó thở nhịp thở nhanh, có hiện tượng hoàng đản ở da và niêm mạc. Chó con dưới 12 tháng tuổi thường chết sau 1 tuần với biểu hiện hạ nhiệt độ, huyết áp tụt và trụy tim mạch.

2. Thể mạn tính

Chó ăn uống bình thường nhưng thường mệt mỏi, gầy xơ xác, kém linh hoạt, ít hoạt động, lông rụng dần. Chó sốt nhẹ 39 - 40^{0}c, sau đó giảm, ít lâu sau lại

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

sốt trở lại. Nước tiểu có màu dỏ nâu. Nếu không điều trị kịp thời chó sẽ chết trong vòng 30 - 40 ngày vì kiệt sức và thiếu máu nặng.

III. PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH

1. Phòng bệnh

- Những nơi đã có bệnh phải định kì kiểm tra máu chó để phát hiện chó bệnh và chó mang trùng, điều trị kịp thời hạn chế lây lan.

- Định kì tẩy uế vệ sinh chuồng nuôi, cũi nhốt chó, nơi ở của chó và môi trường xung quanh để diệt mầm bệnh (phun Chloramin B 0,5% hay ngâm nước vôi 10% trong 10 phút).

- Hàng ngày dọn chuồng thu nhặt phân đổ vào hố xử lý..

- Không thả rông chó mèo, không cho chó mèo bệnh tiếp xúc với bên ngoài để hạn chế lây nhiễm mầm bệnh.

- Chăm sóc và nuôi dưỡng tốt để chó tăng sức đề kháng chống đỡ sự xâm nhập của mầm bệnh.

2. Điều trị

Nguyên tắc chung: điều trị nguyên nhân kết hợp điều trị triệu chứng và trợ sức chăm sóc vật bệnh.

+ Trị lê dạng trùng

- Haemosporidin: thuốc pha với nước muối sinh lý 0,9% theo tỷ lệ 2%, tiêm vào bắp thịt với liều 0,5mg/kg thể trọng, sau 15 ngày có thể tiêm lại lần 2.

- Berenyl (Azidin): thuốc có hiệu lực cao diệt các đơn bào kí sinh, thuốc rất an toàn không gây phản ứng phụ, không tạo ra các chủng đơn bào kháng thuốc. Berenyl sử dụng thích hợp cho cả chó non và chó trưởng thành. Thuốc pha với nước muối sinh lý thành dung dịch 5-10%, tiêm vào bắp thịt hay mạch máu với liều 4-5mg/kgthể trọng. Nếu cần thiết có thể tiêm nhắc lại sau khi tiêm mũi thứ nhất 15-20 ngày.

+ Điều trị triệu chứng

- Chống chảy máu ruột: dùng Vitamin K:

- Trợ sức trợ lực bằng cách tiêm Vitamin B12,Vitamin B1 2,5%, vitamin C 5%, B. Complex...

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

- Bổ sung nước và chất điện giải bằng cách truyền dung dịch sinh lý mặn ngọt đẳng chương với liều 20ml/1kgPcho vật bệnh.

- Trong trường hợp cần thiết có thể dùng phương pháp truyền máu cho chó bệnh

- Chống vàng da hoàng đản: (?)có thể sử dụng một số bài thuốc nam để hạn chế vàng niêm mạc, vàng da, nước tiểu đỏ nâu...

Bài 1: Hạt ý dĩ 50g, vỏ quả cau già (đại phúc bì) 50g, nhân trần 100g, chi tử (quả dành dành) 50g, nước sạch 1500ml. Đun sôi cô đặc còn 500ml, cho chó uống trong ngày chia làm 2-3 lần

Bài 2: Rau má 100g, nghệ già 50g, thân lá rễ cây mã đề 100g. nước sạch 1500ml đun sôi cô đặc còn 500ml cho chó uống hàng ngày

Bài 3: chữa phù toàn thân phù bụng lợi tiểu

Đại phúc bì (vỏ ngoài, vỏ giữa của quả cau phơi khô) cho thêm nước đun sôi sắc đặc cho gia súc uống trong ngày.

GHẺ NGẦM

● Sarcoptes scabiei

Thuộc họ ghẻ sarcoptidae, ký sinh trên nhiều loài gia súc và thú hoang dại. Bệnh gây nguy hại cho trâu, bò, lợn, dê, cừu và cả ngời. Ghẻ ngầm thuộc loài Sarcoptes scabiei, gồm nhiều phân loài, mỗi phân loài ký sinh trên một loài động vật khác nhau.

1. Căn bệnh

Ghẻ đực dài 0,2 - 0,35mm, cái dài 0,35 - 0,5mm, mầu xám bóng hoặc vàng nhạt, thân hình bầu dục hay tròn, mặt lưng có nhiều đường vân song song, khoảng cách giữa các vân có nhiều tơ và vẩy, vẩy hình tam giác có đỉnh hướng về phía sau. Ghẻ không có mắt. Lỗ sinh dục của con cáI ở sau đôi chân thứ III. Lỗ sinh dục con đực ở giữa đôI chân III. Lỗ hậu môn ở phía sau và ở mặt lưng. Ghẻ có 4 đôi chân, mỗi chân có 5 đốt. Ghẻ đực có giác bàn chân hình chuông ở đôi chân I, II, IV, con cái ở đôi chân I và II.

Đầu giả ngắn, có 1 đôi xúc biện và 1 đôi kìm.

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

- Vòng đời phát triển

Ghẻ xâm nhập vào lớp biểu bì, đào thành rãnh, lấy dịch lympho và dịch tế bào làm chất dinh dưỡng. Ghẻ đực và cái giao phối, con cái đẻ từ 40 -50 trứng, sau 3 - 7 ngày trứng nở thành ấu trùng. Ấu trùng giống ghẻ trưởng thành nhưng chỉ có 3 đôi chân và kích thước nhỏ. Sau một thời gian a/t biến thái thành thiếu trùng có 4 đôi chân nhưng chưa có lỗ sinh dục., Thời gian sau a/t biến thái thành ghẻ trưởng thành. Sau thời gian con đực chết, con cái đào rãnh trong biểu bì rồi đẻ trứng và luôn tiến về phía trước, do gai lưng nhọn và luôn hướng về phía sau nên ghẻ không lùi lại được. Ấu trùng sau khi nở đào thủng mái của rãnh thoát ra. Hoàn thành vòng đời hết 15 - 20 ngày.

S. scabiei ký sinh ở da lợn, nghé, chó gây ra bệnh ghẻ ngầm. Bệnh lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp, qua các dụng cụ chăn nuôi, dầy, dép, quần áo của người chăn nuôi. Bệnh phát triển mạnh vào mùa đông và thu. Mùa hạ ít hơn vì ánh sang mặt trời làm ghẻ chết.

2. Triệu chứng

Ghẻ gây ra 3 triệu chứng cơ bản là ngứa, rụng lông và đóng vẩy.

* Ngứa: do ghẻ đào hang, do độc tố trong nước bọt của ghẻ kích thích. Con vật ngứa nhiều thờng dùng chân gãi, cọ sát đIên cuồng vào bất cứ thứ gì nó gặp.

* Rụng lông: lông con vật bị rụng do cọ sát nhiều và do viêm bao chân lông. Lông rụng thành đám tròn, lúc đầu chỉ 2 - 3mm, ngày càng lan rộng ra xung quanh. Do Ghẻ cái không tập trung tại một nơi mà đi khắp cơ thể nên vùng rụng lông ngày càng tăng thêm. Rụng lông do ghẻ ngầm thì rụng toàn bộ và lan toả chậm.

* Đóng vẩy: Những nơi ngứa đều có mụn nớc to bằng đầu đanh ghim, mụn này phát triển xung quanh một con ghẻ cái. Do con vật gãi, cọ sát, mụn bật ra và mất đi, để lại những vết thơng rồi tơng dịch chẩy ra, cùng với máu và những mảnh th-ợng bì khô lại đóng thành vẩy mầu nâu nhạt có khi dầy đến 4mm. Vùng rụng lông tiếp tục tăng rộng và tăng lên nối liền nhau thành mảng. Sau 5 - 6 tháng, da con vật ngày càng bị trụi, đóng vẩy , dầy và nhăn nheo và rất hôi.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

Bệnh ghẻ ngầm làm cho chức năng của da không hoạt động được, con vật ngứa liên tục, giảm ăn, không ngủ được nên gầy dần và chết.

3. Chẩn đoán

Cần chẩn đoán toàn diện, căn cứ vào triệu chứng, bệnh tích. Chính xác nhất là chẩn đoán xét nghiệm.

* Cách lấy bệnh phẩm

Dùng nước ấm hay nước xà phòng, thuốc tím 1% rửa sạch da, cắt lông vùng da có bệnh tích và vùng da lành. Dùng dao cạo mạnh, cạo tới mức chảy máu ra là được. Lấy bệnh phẩm cho vào ống nghiệm rồi xét nghiệm theo các phương pháp sau:

- Phương pháp trực tiếp: Lấy bệnh phẩm cho lên phiến kính, nhỏ vào đó một giọt dầu hoả, ép tấm kính khác lên trên cho nát vẩy, soi dưới kính hiển vi tìm cái ghẻ.
- Phương pháp ngưng cặn: Cho bệnh phẩm vào ống nghiệm chứa sẵn 5 – 10ml NaOH 10%, giữ trong 2 giờ rồi đun nóng trong vài phút, ly tâm trong 5 phút. Lấy cặn ly tâm soi kính tìm trứng, ấu trùng, thiếu trùng và ghẻ trưởng thành.

4. Phòng trị

Chẩn đoán phát hiện con vật bị ghẻ thì phải cách ly ngay và kịp thời điều trị

Dùng thuốc điều trị cần chú ý một số điểm sau

- Phân biệt các loại gia súc vì mỗi loại gia súc mẫn cảm khác nhau với thuốc, từ đó chọn liều thuốc và cách đIều trị thích hợp.
-Tiến hành điều trị: cắt lông, cạo các mụn, tắm xà phòng trước khi dùng thuốc. Tránh không để cái ghẻ vương vãi ra xung quanh.
- Kết hợp các phương pháp dùng thuốc: tắm, bôi, phun, tiêm bắp thịt.
- Dùng thuốc trị ghẻ với thời gian dài. Cần dùng thuốc tiếp lần 2, lần 3 hoặc hơn nữa mới diệt hết ghẻ.
- Đồng thời với việc dùng thuốc diệt ghẻ trên cơ thể động vật, phải vệ sinh chuồng trại, tổng tẩy uế. Diệt ghẻ ngoài môi trường.

* Thuốc trị ghẻ

- Diethyl phthalate (DEP). Bôi lên chỗ có ghẻ, rộng ra xung quanh. Ngày bôi 2 – 3 lần, bôi nhiều ngày.
- Stetocid: 2 – 5%, Bentocid: 2 – 5%, Ditrifon: 1 – 3%, Diazinol: 0,1%.

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

- Ivermectin, liều dùng: 0, 2 – 0,3mg/ 1kg TT., pha với nước cất tiêm dưới da cho con vật. Tiêm 2 – 4 lần. Mỗi lần cách nhau 14 ngày.
- Doramectin (Dectomax): 1ml/ 10kg TT., tiêm 1 tuần 1 lần, tiêm nhiều lần cho đến khi hết triệu chứng lâm sàng.
* Chống viêm và nhiễm trùng
- Ghẻ gây ra viêm da dị ứng vì vậy nên sử dụng các thuốc kháng viêm: hydrococtizon, dexamethason tiêm bắp. Bôi da vùng tổn thương bằng flucinar.
- Dùng kháng sinh khi có nhiễm trùng rõ rệt.

BỆNH MÒ BAO LÔNG
● Demodex canis

1. Nguyên nhân

Mò bao lông có tên là Demodex canis gây ra. Mò có thân hình giun, tròn, bụng dài có nhiều vân ngang; ký sinh ở màng bọc xung quanh của long mao hoặc trong tuyến nhờn của da chó. Vòng đời chưa thật rõ rang, toàn bộ vòng đời của mò bao lông đều trên cơ thể chó.

Sức chịu đựng khá. Có thể sống ngoài cơ thể vật chủ ở chỗ ẩm, tối tới vài ngày. Trong điều kiện thực nghiệm, có thể sống được 21 ngày trên miếng da để ở chỗ ẩm và lạnh.

Lây lan trực tiếp hay tiếp xúc. Gây nhiễm nhân tạo ít có kết quả.

Chó non, chó có lông ngắn, chó gầy yếu hay sau 1 trận ốm nặng, chó thường tắm bằng xà phòng có nhiều xút dễ cảm nhiễm.

Mò bao lông còn gặp ở chó già, khỏe mạnh; thậm chí ở cả người.

2. Triệu chứng

+ ***Dạng ghẻ khô***: Thời kỳ đầu của bệnh thấy chó rụng lông trên da trán, mí mắt, 4 chân da dày cộm thành mầu đỏ xẫm. Chó bệnh bị ngứa thường đưa chân lên để gãi.

+ ***Dạng ghẻ mủ***: trên da của chó xuất hiện những mụn mủ sưng mọng bên trong chứa đầy mủ đặc quánh màu vàng xám. Tại những vùng này da nhăn nheo,

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

lông rụng, lâu ngày các tổ chức chết cùng với dịch viêm bết lại tạo thành các vẩy khô cứng và dày cộm lên. Trường hợp bệnh nặng toàn thân chó trụi lông và đầy những mụn ghẻ có mủ đặc quánh bên trong, ở những vùng da mỏng như bẹn, bụng, lách xuất hiện những ổ áp xe và các ổ áp xe ấy vỡ ra để mủ tự thải ra ngoài có mùi hôi tanh khó chịu

3. Phòng và trị

3.1. Phòng bệnh

Thường xuyên vệ sinh thân thể cho chó tốt nhất là tắm cho chó bằng nước bồ kết, nước lá chát, lá đắng như lá ổi lá xoan, hạt mùi. Chú ý không dùng xà phòng tắm cho chó.

Tiêu độc chỗ ở, chuồng trai, cũi chó bằng các dung dịch sát trùng cloramin B 0,5%, nước vôi 10%; sau khi phun sát trùng cũi, chuồng chó cần phơi khô dưới ánh nắng mặt trời.

3.2. Điều trị

Rất khó điều trị, cần kiên trì, nhiệt tình và tốn kém.

- DEP, Extopa (?), Trinaghe(?), Tribeloda(?): bôi rộng ra xung quanh vùng da bị ghẻ, ngày 2 – 3 lần.
- Hanmectin, Ivermectin, Detomax: tiêm dưới da cho chó. Tiêm nhiều lần, mỗi lần cách nhau 1 – 2 tuần.
- Bôi thuốc flucinar: ngày 2-3 lần, bôi trên bề mặt vùng tổn thương.
- Các kẽ nứt nẻ, nên bôi cồn xanh methylen 3%.
- Dùng kháng sinh khi có nhiễm trùng rõ rệt.
- Khi bệnh nặng: dùng canci clorid 10% tiêm tĩnh mạch.
- Diệt mò ngoài môi trường.

BỆNH VIÊM PHẾ QUẢN

Bệnh viêm phế quản là bệnh viêm niêm mạc đường hô hấp. Viêm phế quản hay phế quản nhỏ sau đó dẫn đến viêm khí quản, nặng hơn dẫn đến viêm phổi.

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

Bệnh hay xảy ra ở chó, mèo khi thời tiết thay đổi từ ấm áp sang lạnh ẩm, thường từ cuối thu sang đông và đến đầu mùa xuân.

I. Nguyên nhân

- Do hít phải khói, bụi, hoá chất gây kích thích đường hô hấp.
- Do bị sặc thức ăn, nước uống.
- Do bị nhiễm cùng lúc một số loài vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp như: Liên cầu trùng (Streptocoocus),Tụ cầu trùng (Staphylocoocus aureus), Klebsiella pneumoniae, Bordetella bronchiseptica.
- Do kế phát của một số bệnh như Carre, viêm ruột, bệnh kí sinh trùng.

II. Triệu chứng

Do kích thích vào đường hô hấp tác động đến dây thần kinh gây ho và nếu tác động lâu sẽ sinh viêm, niêm mạc sưng do viêm hoặc xung huyết sẽ làm hẹp đường hô hấp, các chất phân tiết bịt kín đường hô hấp làm cho chó khó thở, những biểu hiện dặc trưng nhất là:

Vật bị ho và khó thở nhất là vào buổi sáng, lúc đầu ho khan sau trở thành ho ướt và kéo dài. Thở khò khè, có tiếng ran, chảy nước mắt, nước mũi liên tục, có thể kèm theo sốt: 39,5-40,50c, mệt mỏi, bỏ ăn.Viêm phế quản mãn tính thường không sốt, nhưng ho kéo dài có lúc ho ra đờm đặc nhầy.

III. Phòng trị

3.1. Phòng bệnh

- Nơi ở của chó, mèo phải luôn vệ sinh sạch sẽ, ăn uống đủ chất, chỗ nằm phải đảm bảo ấm mùa đông thoáng mùa hè.
- Tiêm vaccin phòng bệnh cho chó định kỳ các loại vaccin sau: dại, carre, viêm gan truyền nhiễn, VRTN do parvovirus, Xoắn khuẩn. Để không bị nhiễm các bệnh truyền nhiễm khác, trên cơ sở đó chó có khả năng đề kháng bệnh về hô hấp.

3. 2. Điều trị

Nguyên tắc chung: Dùng kháng sinh diệt nguyên nhân gây bệnh kết hợp thuốc chữa triệu chứng và thuốc bổ trợ.

- Penicilin + Streptomycin, Gentamycin.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

Hiện hay trên thị trường thuốc thú y có một số biệt dược được sử dụng điều trị bệnh viêm phế quản ở chó, mèo.

- Cefa. Doc: tiêm bắp liều 1ml/5kg thể trọng.
- Ceradoc T: thành phần gồm Cefalexin, Doxycyclin, Sulfadiazin, Trimethoprim và B. comlex thuốc bột uống, liều 1g/ 5kg thể trọng.
- Kanacolin: thành phần gồm Kanamycin sulfate và Ampicilline sodium, tiêm bắp liều 1ml/5kg thể trọng.
- Thuốc chữa triệu chứng: Ephedrin: thuốc giảm ho chống khó thở, tiêm bắp 1-2 ống/ ngày, Dimedron: giảm ho, an thần, tiêm bắp 1-2 ống/ ngày.
- Thuốc trợ sức: Truyền huyết thanh mặn ngọt đẳng trương: 20ml/1kg thể trọng/ ngày, ngoài ra cần thiết sử dụng các loại thuốc trợ sức, trợ lực cho cơ thể như Vitamin B1 2,5%, vitamin C, B.complex, Vitamin B12 kết hợp tăng cường hộ lý, chăm sóc, nuôi dưỡng.

BỆNH VIÊM PHỔI THUỲ

Bệnh viêm phổi thường do kế phát của viêm phế quản hay do bội nhiễm từ các bệnh truyền nhiễm klhác như bệnh Care, viêm khí quản truyền nhiễm ở chó mèo.

I. NGUYÊN NHÂN

- Thường do nhiễm virus đường hô hấp, sau đó là kế nhiễm vi khuẩn như các loại vi khuẩn sau: Pneumococcus, Streptococcus, Klebsiella. Lúc đầu do tác động của virus xâm nhập qua đường hô hấp gây viêm vách phế quản nhỏ, sau lan đến nhu mô phổi hoặc có thể qua đường tuần hoàn làm cho tổ chức phổi yếu đi. Trên cơ sở đó các vi khuẩn có sẵn ở đường hô hấp sẽ phát triển và gây bệnh viêm phổi, nặng hơn gây hoại thư hoặc sinh mủ trong tổ chức phổi
- Do một số ấu trùng kí sinh ở phế quản gây viêm phổi.
- Do một số nấm như: Aspergillus, Histoplasnia.

II. TRIỆU CHỨNG

- Khi mới nhiễm bệnh, con vật mệt mỏi, uể oải, bỏ ăn, sốt cao, niêm mạc đỏ.

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

- Tuy ít ho nhưng ho khó khăn, đau đớn, cơn ho khạc cũng tăng dần lên ngày một nặng, cơn ho sảy ra nhiều vào ban đêm và sáng sớm.
- Thở khó con vật nằm một chỗ, yếu, thở nhanh và nông, biểu hiện thiếu oxy trong máu nên niêm mạc mắt, miệng đỏ xẫm, xung huyết sau tím tái.
- Nếu không điều trị kịp thời, con vật sẽ chết sau vài ngày vì khó thở và suy kiệt.

III. PHÒNG TRỊ

3.1. Phòng bệnh

+ Thực hiện vệ sinh thú y và vệ sinh môi trường, giữ nơi ở khô sạch thoáng mùa hè, kín ấm về mùa đông, phân rác phải dọn hàng ngày cho vào hố tiêu độc.
+ Chăm sóc và nuôi dưỡng tích cực, định kì tiêm phòng các loại vaccin phòng bệnh cho chó, mèo: Carre, Pavovirus, Dại, Viêm gan truyền nhiễm, Xoắn khuẩn. và định kì tẩy giun sán, tăng cường sức đề kháng của cơ thể.
+ Phát hiên sớm vật bị bệnh (ho và khó thở) cách ly điều trị kịp thời.

3.2. Điều trị

Sử dụng thuốc kháng sinh chữa nguyên nhân, thuốc chữa triệu chứng kết hợp thuốc trợ sức và hộ lý.

Sử dụng một trong các lọai thuốc kháng sinh sau đây: Oxytetracyclin, Doxyciclin, Amoxciciclin, ampicillin, Cefalecycin, Erythromycin

Nên phối hợp kháng sinh với sulfamid: tiêm Trinozol (Biseptol) cho chó, mèo; hay uống với liều 40mg/ kg thể trọng/ ngày, kết quả chữa bệnh sẽ tốt hơn.

Thuốc chữa triệu chứng:

+ Giảm ho dễ thở: Ephedrin, tiêm bắp 1-2 ống, ngày tiêm 1-2 lần.
+ An thần giảm sốt, giảm đau: Dimedron tiêm bắp 2ml, ngày tiêm 2 lần.
+ Truyền Ringer lactate 20ml/ kgTT./ ngày.
+ Truyền Glucoza 5% 20ml/ 1kg TT., ngoài ra cần thiết sử dụng các loại thuốc trợ sức, trợ lực , tăng sức đề kháng cho cơ thể như Vitamin B_1 2,5%, Vitamin C, B. complex,Vitamin B_{12} đồng thời chú ý công tác hộ lý, chăm sóc nuôi dưỡng.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

Giới thiệu một số bài thuốc nam chữa bệnh hô hấp ở chó mèo(?)

Bài 1: Chữa ho, viêm khí quản phổi.

Cây mã đề 100g, cam thảo 2g, nước sạch 400ml. Đun sôi 30 phút cho uống trong ngày.

Bài 2: Hoa đu đủ hấp với đường cho uống chữa ho viêm phổi.

Bài 3: Cao mật lợn 400mg cho thêm ít đường cho chó uống trong ngày, uống liên tục 6-7 ngày.

Bài 4: Sài đất 1000g, sâm đại hành 500g, cam thảo nam 100g. Ba vị trên rửa sạch cho thêm nước đun sôi cô đặc nấu thành cao đặc cho uống liều 50ml/lần, ngày uống 2 lần, uống liên tục trong 5-7 ngày.

Bài 5: vỏ cây dâu tằm 50g, vỏ quít 50g, mã đề 50g. Các vị trên rửa sạch cho nước vào đun sôi cô đặc cho uống 50ml/lần, uống liên tục 4-5 ngày.

BỆNH VIÊM MÀNG PHỔI

I. NGUYÊN NHÂN

- Do ảnh hưởng điều kiện ngoại cảnh làm cơ thể suy yếu: do quá lạnh, quá nóng do các tác nhân stress vận chuyển.
- Do kế phát của các bệnh đường hô hấp khác ở chó thường là kế phát bệnh lao phổi

II. TRIỆU CHỨNG

2.1. Thể cấp tính

Chó, mèo bệnh biểu hiện đau ngực, chó thường đi lùi lại, rên rỉ khi có vật ấn vào khe xương sườn, chó thở thể bụng.

Nghe lồng ngức bằng ống nghe thấy có tiếng cọ sát nhẹ, đôi khi như tiếng que gãy soàn soạt hay răng rắc, nếu thể tích chất lỏng nhiều trong xoang ngực thì không nghe thấy tiếng cọ sát nữa. Thân nhiệt tăng, nhiệt độ chỉ giảm khi rút được nước trong phổi ra. Chó, mèo bệnh thường nằm cho dễ thở và cho tim hoạt động dễ hơn, ăn kém, gầy nhanh, mệt mỏi, phờ phạc, uể oải kém hoạt động.

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

2.2. Thể mãn tính

Màng phổi dầy ra, nghe lồng ngực bằng ống nghe không thấy tiếng ran khô và tiếng cọ sát

III. PHÒNG TRỊ

3.1. Phòng bệnh

Giữ ấm về mùa đông, vệ sinh ăn uống sạch sẽ. Bổ xung vitamin cho chó, mèo để tăng sức đề kháng, phòng viêm nhiễm các bệnh khác.

Khi bị nhiễm bệnh đường hô hấp như lao, viêm phế quản phổi, cần thiết phải chữa sớm và triệt để.

3.2. Điều trị

- Cho vật bệnh nằm ở nơi sạch, ấm, kín gió.
- Làm bớt cơn đau ngực bằng cách đắp lạnh.
- Chọc hút lấy bớt nước ở phổi ra đối với chó bằng cách dùng kim tiêm dài, chó để đứng, ngồi hay nằm nghiêng.Sau khi sát trùng cắt lông ở vùng thấp nhất của vùng mất tiếng vang, đó là khoảng cách xương sườn 6 và 8, cách 1 ngón tay trên vùng mất tiếng vang của tim

+Tiêm kháng sinh cho chó mèo: (Tham khảo phần trên)

+ Penicillin G: với chó 500 000UI/ngày, với mèo 200 000UI/ngày, ngày tiêm 2 lần. Kết hợp với Biseptol cho uống liều 40mg/kg thể trọng, chia 2 lần trong ngày.

+ Kanacolin: thành phần gồm: Kanamycin sulfate, colistine Sulfate, Neomycin sulfat. tiêm bắp liều 1ml/5kg thể trọng

+ Lincomycin 10%: tiêm bắp cho chó mèo liều 1ml/5kg thể trong/ngày.

- Kết hợp thuốc bổ trợ: an thần, giảm sốt, giảm đau.

+ Glucoza5%%: truyền tĩnh mạch với liều 20ml/1kgP

+ Vitamin B1 2,5%, vitamin C, B.complex tiêm bắp liều 3-5ml/ngày

Ghi chú: ta có thể sử dụng gây mê nhẹ cho chó để chọc hút nước bằng Zoletil 50 (thuốc gây mê trong thú y) tiêm sâu bắp thịt với liều 1ml/ 10kg thể trọng, sau 5 - 10 phút chó mèo sẽ mê, nằm yên để chọc hút dễ dàng.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

VIÊM BÀNG QUANG

(Tham khảo giáo trình Bệnh nội khoa)

1. Nguyên nhân

- Truyền nhiễm
- Kí sinh trùng
- Sỏi bàng quang

2. Triệu chứng

- Đi tiểu nhiều, đái rắt
- Đau
- Có máu
- X quang phát hiện sỏi

3. Điều trị

- Novocain 2,5% kết hợp với kháng sinh vào bàng quang
- Urotropin
- Kháng sinh nhóm Quinolon
- Vitamin K
- Tán sỏi,bài sỏi
- Lợi tiểu
- Phẫu thuật lấy sỏi

BỆNH VIÊM TỬ CUNG

	Viêm nội mạc tử cung	Viêm cơ tử cung	Viêm tương mạc tử cung
Nguyên nhân	Đỡ đẻ thô bạo Bệnh truyền nhiễm: Baprotiusvulo	Kế phát từ viêm nội mạc tử cung	Kế phát
Triệu chứng Sốt	-Có	-Sốt cao	-Sốt rất cao

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

Đau Thải dịch từ lỗ sinh dục	-Có -Rặn	-Đau nhiều -Rặn nhiều -Dịch có màu nâu đỏ,có mô bào chết,thối,có mùi tanh khắm,khó chịu -Nặng: ảnh hưởng đến sinh đẻ lần sau -Kế phát: chướng hơi, bụng, viêm phúc mạc, viêm vú	-Rất đau -Rặn suốt -Tích nhiều dịch, mủ, dính -Ảnh hưởng đến sức khỏe có thể dẫn đến vô sinh -Biến chứng gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết
Điều trị	-Rửa bằng dung dịch sát trùng -Thuốc co bóp tử cung -Bơm kháng sinh vào TC kết hợp Novocain -Kháng sinh toàn thân -Tăng sứ đề kháng	-Không dùng -Có thể dùng -Có dùng -Có dùng -Có dùng	-Không dùng -Không dùng -Có thể dùng -Có dùng Có dùng -Phẫu thuật cắt bỏ TC

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

BỆNH CO GIẬT TRƯỚC VÀ SAU KHI ĐẺ

Bệnh co giật do thiếu canci ở gia súc cái nói chung và ở chó, mèo nói riêng là một quá trình bệnh lý thường sảy ra trước khi đẻ, trong và sau khi đẻ thậm chí ngay tới khi cai sữa cho con. Bệnh co giật do thiếu canxi có thể sảy ra trước hoặc sau khi đẻ

A. BỆNH CO GIẬT TRƯỚC KHI ĐẺ

1. Nguyên nhân

- Chủ yếu do nuôi dưỡng không tốt khẩu phần ăn thiếu Ca, P
- Tỷ lệ Ca/P không thích hợp, do Ca thiếu, P thừa gây nên hiện tượng co giật.
- Do rối loạn hoạt động của tuyến cận giáp (Parathyroides) dẫn đến lượng canxi trong máu từ 10-12% giảm xuống còn một nửa.

2. Triệu chứng

- Chó, mèo đi lại bồn chồn, nôn mửa nhanh, sốt cao trên 410c.
- Hai chân sau yếu run rẩy, đứng không vững, đi lại khó khăn, thường đi siêu vẹo sau đó chó nằm ruỗi thẳng chân, không đứng lên được, cơ run, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật con vật thở hổn hển, thở rốc, nước dãi chảy tự do quanh miệng
- Bệnh có thể kéo dài liên tục vài tiếng, có khi tới vài ngày nếu không can thiệp ngay sẽ lên cơn co giật liên tục, sau đó bại liệt nằm một chỗ, bại liệt kéo dài làm cơ của chân sau bị teo, thối loét da thịt và vật thường bị tử vong trong trạng thái bại huyết

B. BÊNH CO GIẬT SAU KHI ĐẺ

Bệnh thường xảy ra đột ngột sau khi đẻ trong vòng 3-5 ngày, chó mèo thường có triệu chứng đặc trưng: run rẩy, co giât, quay cuồng, đầu mất phương hướng, đập đầu vào tường rồi 4 chân mất cảm giác sau đó liệt hẳn.

1. Nguyên nhân

Do trong giai đoạn mang thai nhất là gai đoạn cuối, chó, mèo không được cung cấp đầy đủ Canxi, phốt pho trong khi đó thai đang phát triển nhanh bộ

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

xương cần một lượng lớn canxi. Hơn nữa sau khi đẻ, chó cái, mèo cái lại phải tiết sữa để nuôi con mà trong sữa đòi hỏi phải có can xi từ đó làm cho hàm lượng canxi giảm xuống đột ngột trong máu gây ra bệnh co giật của chó mèo sau khi đẻ.

2. Triệu chứng

Bệnh tiến triển nhanh, từ khi bắt đầu có dấu hiệu lâm sàng đầu tiên đến xuất hiện các triệu chứng điển hình không quá 12 giờ.

Chó mèo bồn chồn ủ rũ, mắt lờ đờ, không muốn đi lại, chân sau lảo đảo, đứng không vững

Run rẩy, các bắp thịt rung liên tục sau đó xuất hiện những cơn co giật. Chó thở mạnh, chảy rớt dãi, không đi lại được.Những triệu chứng này xuất hiện rất nhanh, trong thời gian ngắn nên hay nhầm với bệnh say nắng hay nhiễm trùng huyết cấp tính. Nếu không cứu chữa kịp thời thì có tới 60% số chó mèo sẽ chết sau 12-48 giờ co giật. Nhiều trường hợp chó sau khi đẻ vài giờ đã chết vì co giật.

Một số trường hợp bệnh nhẹ chó mèo chỉ thể hiện: khô mũi, ăn ít, đi lại khó khăn, siêu vẹo. Tuy nhiên hậu quả cuối cùng không chết nhưng cũng liệt chân, thở khó khăn, lưỡi luôn luôn thè ra kèm theo dãi dớt do liệt hầu. Chó mèo suy yếu nhanh, mệt mỏi, không cho con bú

3. Phòng trị

a. Phòng bệnh

Trong giai đoạn có chửa và nuôi con nên cho ăn đủ chất dinh dưỡng, đủ chất khoáng và vitamin, nhất là Ca và P.

- Hàng ngày nên bổ sung vào thức ăn bột xương nghiền, bổ xung thêm ốc, cua, tôm, hến, sụn, xương trong khẩu phần.

- Cho chó mèo chửa ra hoạt động ngoài trời để tăng thêm lượng vitamin D_2, D_3.

b. Chữa bệnh

- Tiêm dung dịch gluconat canci hay canci clorid vào tĩnh mạch cho chó với liều 3-5ml/con, tiêm liên tục trong 3-5 ngày với mèo tiêm luconat canci vào bắp thịt.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

Calcium fort: thành phần gồm cancium gluconate 20% tiêm bắp cho chó liều 10ml/con/ngày, mèo 5ml/con/ngày.

- Thuốc bại liệt cặp: thuốc gồm 1 cặp 2 ống: 1 ống chứa cancium gluconate, 1 ống chứa vitamin nhóm B, khi tiêm bắp trộn 2 ống và tiêm cho chó liều 10ml/con/ngày, mèo 5ml/con/ngày

+ Trợ tim mạch:

Tiêm cafein 5% liều 2-3ml/con, tiêm long não nước 5%, liều 2-3ml/con nếu có hiện tượng hạ nhiệt độ.

+ Trợ sức, trợ lực bằng cách:

Tiêm bắp vitamin B1, liều 5ml/con chó, 3ml/con mèo.

Tiêm bắp vitamin C 5% liều 5ml/con chó, 3ml/con mèo.

* Kinh nghiệm của nhân dân có thể dùng một số bài thuốc nam như sau(?):

+ **Bài 1**:

Bột xương nung	50g
Bột đỗ tương	30g
Bột cá hay bột tôm	30g
Sữa bột	50g

Trộn đều và cho vào thức ăn hàng ngày của chó mèo mỗi ngày 5-10g, cho ăn liên tục 10-15 ngày.

+ **Bài 2**: Mẫu lệ (vỏ hầu): 20g, tán nhỏ thành bột mịn, cho lẫm vào thức ăn hàng ngày, của chó mèo cho ăn liện tục 10-15 ngày.

HIỆN TƯỢNG CHỬA GIẢ

● Pseudocyecis

I. Nguyên nhân

Cho đến nay nguyên nhân gây lên hiện tượng chửa giả ở chó mèo chưa được khẳng định chắc chắn; nhưng nhiều tác giả đã cho rằng có thể do hoạt động kéo dài của thể vàng.

II. Triệu chứng

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

Sau khi động dục một thời gian, chó cái có triệu chứng chửa. Bụng căng dần, tuyến vú tăng sinh.

Núm vú phát triển, bầu vú căng và vắt ra sữa, ở giai đoạn cuối chó cái có hiện tượng tìm chỗ để đẻ nhưng thực ra không có thai trong bụng (khám bụng bằng sờ nắn, nghe tim thai và siêu âm xem có thai thật không).Tính tình chó thay đổi. Sau khoảng 60 ngày chó cái làm tổ ở nơi tối, coi đồ chơi hay giầy dép như là con của chính mình.

Con vật có biểu hiện rối loạn tiêu hoá, rối loạn điều tiết nhiệt có lúc thân nhiệt tăng có lúc nhiệt độ thấp .

III. Điều trị

Thường những chó này không cho sinh sản nữa, nuôi để làm cảnh hoặc để trông nhà. Vì vậy khi ngừng tiết sữa, thực hiện phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng và tử cung

+ Testosteron: tiêm bắp liều 10-50mg, kết thúc hiện tượng chửa giả nhanh chóng.

+ Oestrogen: tiêm bắp liều 1-2mg/con, tiêm 3 lần mỗi lần cách nhau 48 tiếng, để làm ngưng trạng thái chó chửa.

+ Progesterol: Tiêm bắp cho chó liều 2-5mg/lần, thường phối hợp với vitamin E liều 2mg/kg thể trọng.

+ Prolan B: Tiêm bắp liều 500UI cho chó dưới 25kg và liều 1000UI cho chó trên 25kg.

+ Estrumate: do hãng Coopers Ang Quốc sản xuất, tác dụng tương tự như Protasgladin: tiêm bắp liều 0,3- 0,5ml/lần, có tác dụng nhanh chóng kết thúc hiện tượng mang thai giả ở chó.

HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY

1. Nguyên nhân

Do vi khuẩn, vi rút, do thức ăn kém phẩm chất, do giun sán đường ruột, do kí sinh trùng đường máu, do trúng độc hoá chất,…

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

Ngoài ra còn do cầu trùng, amip

2. Triệu chứng

- Tiêu chảy xen kẽ táo bón
- Tiêu chảy dữ dội, xuất huyết ruột và các lỗ tự nhiên (mắt, mũi, miệng, hậu môn, tai, sinh dục)

Mức độ từ nhẹ đến nặng tuỳ thuộc vào tác nhân gây bệnh. Nặng nhất là do virus gây lên, nhẹ nhất là do thức ăn.

3. Điều trị

- Atropin sulfat: tác dụng chống co thắt cơ trơn. (dùng trong trường hợp do virus, vi khuẩn, thức ăn, trúng độc).
- Điều chỉnh chế độ ăn: ăn kiêng, kiêng ăn thức ăn nhiều protit, lipit.
- Truyền dịch:

+ Nếu nguyên nhân là virus, vi khuẩn, trúng độc: dùng dung dịch đẳng trương (gluco 5%, NaCl 0,9%)

+ Nguyên nhân do trúng độc hoá chất, thức ăn kém phẩm chất có thể dùng than hoạt tính để hấp phụ chất độc.

- Kháng sinh: gentamycin, kanamycin, enroflocacin, oflocacin…
- Sulfamid: sulfaguamidin, biseptol…
- Thuốc tẩy giun sán.
- Dùng vitamin tăng sức đề kháng.

PHƯƠNG PHÁP CẮT ĐUÔI CHÓ

1. MỤC ĐÍCH

- Lúc đầu đối với các giống chó săn,hoạt động nhiều nơi hoang dã, rừng núi hiểm trở, người ta phải chủ động cắt đuôi cho khỏi vướng, tránh chấn thương trong lúc săn mồi, tấn công…
- Sau này chúng trở thành "mốt" đối với một số giống chó nhất định.

2. PHƯƠNG PHÁP

2.1. Buộc chun, thắt chỉ

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

- Đơn giản, mọi người đều có thể tự mình làm thủ thuật này cho chó sau 7-10 ngày tuổi.
- Kỹ thuật này có một số nhược điểm:
+ Phần đuôi sau nút buộc bị chết (hoại tử) dần dần gây viêm sưng và rất đau đớn cho chó con.
+ Chó bị "chột" lớn chậm, thậm chí có con nhiễm trùng máu và chết.
+ Mặt khác sau 7 ngày, phần xương đuôi đã chuyển từ sụn thành xương cứng, lâu lành.

2.2. Cắt đuôi ngay sau khi đẻ

Ưu điểm: đuôi hoàn toàn dưới dạng sụn, cắt chó ít đau và chóng lành. Vị trí cắt tuỳ theo sở thích.
+ Kỹ thuật cắt ngay sau khi đẻ:
- Bôi cồn sát trùng rửa sạch hậu môn, đuôi.
- Dùng 1 chiếc panh kẹp máu có răng, kẹp chặt đúng chỗ muốn cắt.
- Lấy tay cầm phần đuôi ngoài chiếc panh vặn dứt khoát, đuôi rời ra rất dễ. Giữ panh trong 30 giây rồi nhả ra. Chấm cồn Iod 5% vào vết cắt (thực ra là vết vặn vì dạng sụn không phải cắt) và thả luôn vào cho mẹ liếm. Không phải khâu.

c. Phẫu thuật cắt đuôi chó

Ưu điểm: Có thể sử dụng với chó khi đã lớn. Tương đối đơn giản và an toàn

Kỹ thuật cắt

+ Sát trùng vùng hậu môn và đuôi bằng cồn 90^0
+ Gây tê: sử dụng novocain 0.25% gây tê bên trên vị trí muốn cắt (gây tê dẫn truyền) và gây tê thấm xung quanh vị trí cắt
+ Khâu lược bên trên vị trí muốn cắt, sau đó thắt chặt. Mục đích là hạn chế chảy máu trong quá trình phẫu thuật
+ Dùng dao cắt lớp da xung quanh đuôi, cách nơi muốn cắt 1-2 cm về phía dưới
+ Khi xương đuôi bộc lộ, tách lớp da đuôi và xương đuôi về phía trên. Với chó to dùng chỉ thắt nút hai động mạch đuôi tại vị trí bên trên nơi cắt để hạn chế chảy máu. Sau đó dùng dao cắt đuôi tại vị chí giữa hai đốt

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

+ Lau sạch máu ở đuôi, bôi bột sulfamid hoặc kháng sinh vào vị trí vừa cắt sau đó khâu phần da lại.

Hộ lý chăm sóc

- Giữ vệ sinh cho chó

THIẾN CHÓ MÈO CÁI

1. Chuẩn bị

- Khi con vật trong thời gian động dục không lên thực hiên phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng vì khi đó các mạch máu ở đường sinh dục xung huyết sẽ gây chảy máu rất nhiều, rất khó cầm máu.
- Bắt con vật nhịn đói 18 – 24 giờ.
- Gây mê: sử dụng Zoletil, Thiobentan Natri, Ketamin với liều để gây mê khoảng 45-60 phút
- Cố định: nằm ngửa, với tư thế đầu thấp mông cao.
- Vệ sinh: cắt, cạo lông, sát trùng vùng phẫu thuật.
- Gây tê cục bộ xung quanh nơi mổ bằng novocain 0,25%.
- Vị trí vết mổ: giữa bụng, ngang mức đôi vú áp cuối cùng hơi nhích lên phía đầu. Ở chó mèo, sừng tử cung, ống dẫn trứng và buồng trứng đều có dây chằng, vì vậy nó nằm gần như song song với cột sống vùng lưng, buồng trứng hướng về phía đầu của con vật; chính vì vậy khi mổ mà khó tiếp cận được buồng trứng thì rạch vết mổ tiến về phía đầu.

2. Các bước tiến hành

- Rạch da: dùng dao rạch một đường thẳng dứt khoát tại đường trắng.
- Bộc lộ đường trắng (cân mạc của 4 cơ vùng bụng).
- Rạch giữa đường trắng.
- Phúc mạc: mỏng, dễ rách vì vậy không thọc thủng mà dùng panh nhấc lên cắt cho thẳng.

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

- Tìm sừng tử cung: là ống nhỏ, thẳng, nhạt màu và đôi khi cứng hơn ruột (khi lần lại phía đuôi của con vật sẽ gặp ngã 3 tử cung).
- Lần dọc theo tử cung về phía đầu con vật.
- Bộc lộ buồng trứng. Buồng trứng nhỏ và được loa kèn bọc kín.
- Khi tìm được buồng trứng dùng panh kẹp (nên dung panh cong) kẹp ngang ống dẫn trứng (không đưa hẳn ra ngoài được vì có dây chằng). Lấy buồng trứng ra, sau đó dùng kim chỉ thắt mạch máu ở sừng tử cung và dây chằng (nên thắt 2 nút về 2 phía: 1 nút thắt các mạch máu dọc theo ống dẫn trứng, 1 nút thắt các mạch máu song song với cạnh trước màng treo buồng trứng.. Chú ý nút thắt phải thật chặt, sau đó cắt và kiểm tra xem máu có chảy không, nếu còn chảy máu thì phải thắt bổ xung để cầm máu. Làm tiếp tục với buồng trứng còn lại.
- Đưa các cơ quan nội tạng vào ổ bụng.
- Khâu
+ Phúc mạc và đường trắng khâu chung sử dụng khâu vắt liên tục
+ Cơ khâu nút đơn sau đó khâu gấp mép. Sau đó cho bột kháng sinh hoặc Sulfamid để chống nhiễm khuẩn.
+ Da khâu nút đơn

3. Hộ lý chăm sóc

- Cho con vật ăn sạch, uống sạch, ăn thức ăn nhiều dinh dưỡng và dễ tiêu.
- Sử dụng một liệu trình kháng sinh khoảng 2-3 ngày để đề phòng nhiễm khuẩn
- Sau 7-10 ngày cắt chỉ.
- Chú ý: Sau 1-2 ngày mà con vật vẫn chưa đại tiện được thì khả năng lớn là đã khâu vào ruột vì vậy phải tháo chỉ khâu lại.

PHƯƠNG PHÁP CẮT TAI CHÓ
PHƯƠNG PHÁP MỔ ĐẺ CHÓ MÈO
PHƯƠNG PHÁP CẮT NHÃN CẦU

Các phẫu thuật trên như phần ***Ngoại khoa thú y thực hành*** đã học.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. CÁC TÁC GIẢ TRONG NƯỚC

1.1. Nguyễn Văn Biện (2001). Bệnh chó, mèo./ Nhà xuất bản trẻ.// TP Hồ Chí Minh.

1.2. Vương Đức Chất, Lê Thị Tài (2004). Bệnh thường gặp ở chó mèo và phương pháp phòng trị./ Nhà xuất bản Nông nghiệp.// Hà Nội.

1.3. Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2001). Sinh sản gia súc./ Nhà xuất bản Nông nghiêp.// Hà Nội.

1.4. Phạm Khắc Hiếu, Lê Thị Ngọc Diệp (1997). Dược lý học thú y./ Nhà xuất bản Nông nghiệp.// Hà Nội.

1.5. Phạm Khắc Hiếu, Bùi Thị Tho (1994).Đông dược thú y – phần đại cương./ Nhà xuất bản Nông nghiệp.// Hà Nội.

1.6. Nguyễn Thị Huyền (2007). Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý chủ yếu của bệnh Carre trên chó và phương pháp phòng trị./ Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp.// Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

1.7. Huỳnh Văn Kháng (2003). Phẫu thuật ngoại khoa thú y./ Nhà xuất bản Nông nghiệp.// Hà Nội.

1.8. Huỳnh Văn Kháng (2003). Bệnh ngoại khoa gia súc./ Nhà xuất bản Nông nghiệp.// Hà Nội.

1.9. Huỳnh Văn Kháng (2006). Giáo trình Ngoại khoa thú y - Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp./ Nhà xuất bản Hà Nội.

1.10. Huỳnh Văn Kháng (2000). Hướng dẫn thiến và phẫu thuật chữa bệnh cho gia súc gia cầm./ Nhà xuất bản Nông nghiệp.// Hà Nội.

1. Phạm Văn Khuê, Phan Lục (1996). Ký sinh trùng thú y./ Nhà xuất bản Nông nghiệp.// Hà Nội.

1.11 Phạm Sĩ Lăng, Bùi Văn Đoan, Trần Anh Tuấn, Hồ Đình Chúc (1989). Kỹ thuật nuôi dạy, phòng bệnh cho chó cảnh và chó nghiệp vụ./ Nhà xuất bản Nông nghiệp.// Hà Nội.

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

1.12. Hồ Văn Nam (1997). Bệnh nội khoa gia súc./ Nhà xuất bản Nông nghiệp.// Hà Nội
1.13. Hồ Văn Nam (2001). Chẩn đoán lâm sàng thú y./ Nhà xuất bản Nông nghiệp. Hà Nội.
1.14. Trần Thanh Phong (1996). Một số bệnh truyền nhiễm chính trên chó./ Trường Đại học Nông lâm. Viện Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
1.15. Nguyễn Vĩnh Phước, Hồ Đình Chúc, Nguyễn Văn Hanh, Đặng Thế Huynh (1978). Giáo trình Bệnh truyền nhiễm gia súc./ Nhà xuất bản Nông nghiệp.// Hà Nội.
1.16. Vũ Như Quán, Phạm Khắc Hiếu (2008). Ngoại khoa thú y./ Nhà xuất bản Giáo dục.// Hà Nội.
1.Phạm Ngọc Quế (2002). Bệnh dại và phòng dại cho người và chó./ Nhà xuất bản nông nghiệp.// Hà Nội.
1.17. Phạm Ngọc Thạch, Hồ Văn Nam, Chu Đức Thắng (2006). Bệnh Nội khoa gia súc./ Nhà xuất bản Nông nghiệp.// Hà Nội.
1. Phạm Ngọc Thạch (2006). Những bí quyết chẩn đoán bệnh cho chó./ Nhà xuất bản Nông nghiệp.// Hà Nội.
1.18. Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Đường, Nguyễn Khắc Tuấn, Nguyễn Thị Bích Lộc, Nguyễn Bá Hiên (2004). Vi sinh vật học đại cương./ Nhà xuất bản Nông nghiệp.// Hà Nội.
1.19. Nguyễn Xuân Tịnh, Tiết Hồng Ngân, Nguyễn Bá Mùi, Lê Mộng Loan (1996). Sinh lý học gia súc./ Nhà xuất bản Nông nghiệp.// Hà Nội.
1.20Nguyễn Phước Tương (2000). Bệnh ký sinh trùng của vật nuôi và thú hoang lây sang người (tậpI)./ Nhà xuất bản Nông nghiệp.// Hà Nội.
1.21. Nguyễn Phước Tương (2002). Bệnh ký sinh trùng của vật nuôi và thú hoang lây sang người (tậpII)./ Nhà xuất bản Nông nghiệp.// Hà Nội.
1.22. Phạm Xuân Vân (1982). Giáo trình Giải phẫu gia súc./ Nhà xuất bản Nông nghiệp.// Hà Nội.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)

II. VĂN BẢN CỦA TỔ CHỨC CƠ QUAN

2.1.Bộ Y tế(2004). Dược thư Quốc gia Việt Nam./ Hội đồng dược điển Việt Nam.// Hà Nội.

2.1. Bộ Y tế(2007). Dược thư quốc gia Việt Nam, Bản bổ sung./ Hội đồng dược điển Việt Nam. Nhà xuất bản Y học.// Hà Nội.

III. CÁC TÁC GIẢ NƯỚC NGOÀI

3.1. Beliakov I.M., V.A. Lukianovxki và các tác giả (1996). Bệnh của chó./ Nhà xuất bản "Niva Ratxii".// Cộng hoà Liên bang Nga.

3.2. Lukianovxki V.A., I.M. Beliakov và các tác giả khác (1998). Chữa bệnh cho chó./ Nhà xuất bản "Niva Ratxii".// Cộng hoà Liên bang Nga.

3.3. Morgan R.V. (1997). Sổ tay thực hành động vật nhỏ./ Nhà xuất bản W.B. Saunders. Philadelphia.// U.S.A.

3.4. Preston Hoskins H., J.V. Lacroix, Karl Mayer (1966). Bệnh của chó./ Nhà xuất bản American Veterinary Publications.// U.S.A.

3.5. Slatter D.H. (1985). Ngoại khoa động vật nhỏ./ Nhà xuất bản W.B. Saunders Compani. Philadelphia.// U.S.A.

Danh sách những người tham gia biên tập

1. Cam Ngọc Khoa
2. Nguyễn Thị Khuê
3. Nguyễn Ngọc Khuê
4. Phan Thị Lan Chi
5. Đặng Đình Thiền
6. Lưu Trọng Ý

Các sai sót phát hiện được, xin các Bạn gửi về cho: **Vũ Như Quán**

Bộ môn Ngoại – Sản. Khoa Thú y.

Downloaded by Tran Viet Huy (K17 QN) (huytvqe170161@fpt.edu.vn)